高性价比睡眠指南

用最少的钱、时间和毅力，换回最多的好睡眠

认识睡眠 · 你到底需要多少睡眠 · 固定作息与起床时间 · 光照与昼夜节律 · 卧室环境与睡眠…

203 条建议　A 级证据 59 条　17 条原始文献链接　可按性价比筛选

讲睡眠到底是怎么回事，讲你到底需要多少睡眠，讲怎么靠固定作息、晨光、黑暗、凉爽的卧室把好睡眠要回来，讲咖啡因和酒精怎么偷走睡眠，讲运动、午睡、压力与失眠，讲助眠补剂和 CBT-I 哪种真有用，讲手环数据怎么别被它带焦虑，也讲打鼾、轮班、时差、孕期和老年人的特殊做法。203 条建议，每条写明花掉什么、换回什么、证据有多硬，来源只引期刊论文和官方文件。不用全做：这是按性价比排好的备选单，不是任务清单——挑走一两条就算数。

生成于 2026-10-12 09:15（北京时间） · 正文提交 07370c5

正文以在线版为准：https://kexin1409.github.io/how-to-sleep-better/

在线检索与本 PDF 的最新版都在 https://github.com/kexin1409/how-to-sleep-better

目录

前言 1

各节简介 4

1. 认识睡眠：你的身体每晚在做什么 5

2. 你到底需要多少睡眠：按年龄看，别靠感觉 9

3. 固定作息与起床时间：最便宜的安眠药 13

4. 光照与昼夜节律：用光把生物钟拨准 17

5. 卧室环境与睡眠卫生：把房间调成"该睡的样子" 21

6. 寝具、睡衣与睡姿：把"睡的姿势"也排进预算 25

7. 饮食、咖啡因与酒精：什么在偷走你的睡眠 29

8. 运动与睡眠：白天动一动，晚上睡得沉 33

9. 屏幕、电子设备与睡前仪式：把"关机"也排进日程 37

10. 午睡的学问：小睡是把双刃剑 41

11. 压力、焦虑与入睡困难：脑子停不下来怎么办 45

12. 失眠与 CBT-I：慢性失眠到底怎么治 49

13. 助眠补剂与药物：什么真有用，什么只是昏你 53

14. 睡眠监测与数据：别被手表带焦虑 57

15. 常见误区与谣言：流传最广的睡眠说法，哪些错了 61

16. 特殊人群与场景：轮班、时差、打鼾、孕老幼怎么办 65

前言

讲睡眠到底是怎么回事，讲你到底需要多少睡眠，讲怎么靠固定作息、晨光、黑暗、凉爽的卧室把好睡眠要回来，讲咖啡因和酒精怎么偷走睡眠，讲运动、午睡、压力与失眠，讲助眠补剂和 CBT-I 哪种真有用，讲手环数据怎么别被它带焦虑，也讲打鼾、轮班、时差、孕期和老年人的特殊做法。203 条建议，每条写明花掉什么、换回什么、证据有多硬，来源只引期刊论文和官方文件。不用全做：这是按性价比排好的备选单，不是任务清单——挑走一两条就算数。

这本书想回答的问题

问题	去哪看
睡眠到底是什么、昼夜节律和睡眠压力怎么运作？	1. 认识睡眠
不同年龄段到底需要多少睡眠，有没有短睡者？	2. 你到底需要多少睡眠
固定起床时间、规律作息、补觉和社交时差怎么处理？	3. 固定作息与起床时间
晨光、蓝光、夜灯、晒太阳怎么影响昼夜节律？	4. 光照与昼夜节律
卧室的温度、黑暗、噪音、床品怎么布置最助眠？	5. 卧室环境与睡眠卫生
床垫、枕头、睡衣、睡姿怎么选？	6. 寝具、睡衣与睡姿
咖啡因、酒精、晚餐、喝水、夜宵怎么影响睡眠？	7. 饮食、咖啡因与酒精
白天运动、睡前运动、瑜伽对睡眠各有什么用？	8. 运动与睡眠
屏幕、电子设备、睡前仪式怎么安排？	9. 屏幕、电子设备与睡前仪式
午睡该睡多久、几点睡、咖啡盹有没有用？	10. 午睡的学问
压力、焦虑、脑子停不下来、入睡困难怎么破？	11. 压力、焦虑与入睡困难
失眠、CBT-I、刺激控制、睡眠限制、安眠药怎么选？	12. 失眠与 CBT-I
褪黑素、镁、缬草、抗组胺、处方安眠药哪种真有用？	13. 助眠补剂与药物
手环、多导睡眠监测、睡眠数据焦虑怎么看？	14. 睡眠监测与数据
流传最广的睡眠说法里，哪些是错的？	15. 常见误区与谣言
轮班、倒时差、打鼾、孕期、老人、青少年、婴幼儿分别怎么办？	16. 特殊人群与场景

怎么读

- 不用全做：这是一份按性价比排好的备选单，不是任务清单。挑走一两条就算数，剩下的放着，需要时再回来查。

- 想按条件挑：打开在线检索页（https://kexin1409.github.io/how-to-sleep-better/），可以按关键词、章节、证据等级来筛，也可以按「花不花钱、花多少时间、要不要毅力」这三样筛，几个条件能叠着用。页面上的内容直接取自 book/ 目录里的正文，正文一改，页面跟着改。
- 条目之间会互相指路（「见第 4 节第 7 条」这种）：在线检索页里点一下就能跳过去。在这份 PDF 里点不动，但每处指路都写明了指向哪一条，不翻过去也知道说的是什么。
- 想按顺序读：每节内的条目按性价比从高到低排列，从每节前几条开始看就行。
- 只想看结论最硬的：在在线检索页里勾选证据等级 A，只留下有具体数字、来自荟萃分析或大型试验的 59 条。
- 只想看最值得做的：勾选性价比「极高」，得到 18 条几乎不花钱、不花时间、不太需要毅力，收益又落在最大一档的条目。
- 想让 AI 帮你查：仓库里带了正文，把问题原样丢给能读文件的 AI 助手，让它先查相关条目、再按书里的口径回答，并注明出自第几节第几条。查不到就说查不到，不自己编数字。

证据分级

等级	含义
A	有具体数字可查，出处是多项研究合并起来的荟萃分析、跟踪很多人很多年的大型队列，或者随机分组的试验（RCT），能说出降了多少（HR、RR、下降百分比）
B	有研究支持，但说不出一个确切数字；或者只有小样本、单独一项研究撑着
C	作者自己的经验，或者大家公认的做法，没有直接的研究文献

全书 203 条中 A 级 59 条、B 级 53 条、C 级 91 条，另有 0 条标注了争议、0 条含待核实内容。有争议的条目会在备注里列出反方证据。所有来源只引原始文献（期刊论文附 DOI 或 PubMed 链接，或 WHO/CDC/国家卫健委等官方机构报告），不引二手转述。

性价比档

证据等级只回答「这个数字可不可信」，不回答「这件事值不值得做」。所以每条还另外标了两样：收益量级（好处有多大：大/中/小）和口径（换回的是哪一类东西：慢病/死亡率/时间等）。拿收益量级加上三项成本（钱、时间、毅力），合出一个性价比档：几乎不花什么成本、换回的好处又大的，是「极高」；其次「高」，再次「一般」。不同口径之间不做比较——「死亡率低 12%」和「每天省 10 分钟」不在一把尺子上。全书 203 条中性价比极高 18 条、高 83 条、一般 102 条。

每条建议长这样

```
### 2. 早上晒 10–30 分钟光，把生物钟拨正
<!-- 成本标签: 钱=0 时间=少 毅力=否 收益=大 口径=节律 -->
- 成本：零，多走几步到窗边或户外，约 10–30 分钟。
- 说人话：起床后 1 小时内到窗边或户外，哪怕阴天也行——室外的光强是室内的几十到上百倍。这能把生物钟拨到准确相位，晚上该困的时候准时困。这是全书性价比最高的一条之一。
- 收益：多项研究显示晨光暴露与更早的入睡时间、更好的夜间睡眠相关；对"冬天提不起劲、早上起不来"尤其管用。
- 证据等级：A
- 来源：Reid KJ 等 (2014). Timing and intensity of light correlate with circadian rhythm. Sleep Med.；Wirz-Justice A 等清晨光治疗综述
- 备注：隔着玻璃会打折，户外再阴天也远强于室内灯；冬天日照短可用光疗灯（第 8 条）。
```

「说人话」把「收益」栏里研究里的写法，翻成「入睡快了、夜里少醒」这样的日常说法。它只用「收益」栏已经写到的内容，不添新数字，只看这一行就够拿主意。「收益」栏里原样留着全部数字，想自己核对就看那一栏。

各节简介

1. 认识睡眠：你的身体每晚在做什么：这一节把睡眠的原理讲清楚——昼夜节律、睡眠压力、睡眠分期。口径：理解睡眠机制，减少焦虑。

2. 你到底需要多少睡眠：按年龄看，别靠感觉：这一节给出各年龄段的时长参考，以及怎么判断"你自己的"真实需求。口径：睡眠时长与需求评估。

3. 固定作息与起床时间：最便宜的安眠药：这一节专讲"作息"。口径：作息规律性。

4. 光照与昼夜节律：用光把生物钟拨准：这一节讲最被低估的一件事——光。口径：昼夜节律。

5. 卧室环境与睡眠卫生：把房间调成"该睡的样子"：这一节讲环境——温度、光、噪音、床的用途。口径：睡眠环境与卫生。

6. 寝具、睡衣与睡姿：把"睡的姿势"也排进预算：这一节讲床具本身和睡姿。口径：寝具与睡姿。

7. 饮食、咖啡因与酒精：什么在偷走你的睡眠：这一节讲吃进嘴里的东西怎么影响睡眠。口径：饮食与物质。

8. 运动与睡眠：白天动一动，晚上睡得沉：这一节讲运动。口径：运动与睡眠。

9. 屏幕、电子设备与睡前仪式：把"关机"也排进日程：这一节讲睡前的最后一道关——屏幕和仪式感。口径：屏幕与睡前行为。

10. 午睡的学问：小睡是把双刃剑：这一节讲午睡。口径：午睡。

11. 压力、焦虑与入睡困难：脑子停不下来怎么办：这一节讲最普遍的场景——不是身体问题，是"脑子不肯关机"。口径：心理与放松。

12. 失眠与 CBT-I：慢性失眠到底怎么治：这一节讲当睡眠真的成了"病"。口径：失眠诊疗。

13. 助眠补剂与药物：什么真有用，什么只是昏你：这一节讲"实在想用药/补剂"时的边界。口径：补剂与用药。

14. 睡眠监测与数据：别被手表带焦虑：这一节讲手环、App 和多导睡眠图。口径：数据与工具。

15. 常见误区与谣言：流传最广的睡眠说法，哪些错了：这一节把最常听到的"睡眠常识"一条条过一遍，标出真假。口径：误区辨析。

16. 特殊人群与场景：轮班、时差、打鼾、孕老幼怎么办：这一节把前面分散在各节的"特殊情形"收拢：不同人群的真实做法。口径：特殊人群。

1. 认识睡眠：你的身体每晚在做什么

这一节把睡眠的原理讲清楚——昼夜节律、睡眠压力、睡眠分期。先把"为什么"弄明白，后面那些"怎么做"才不是玄学。口径：理解睡眠机制，减少焦虑。

1. 睡眠不是关机，是另一套系统在开机

- 成本：零。
- 说人话：睡着后大脑并没有休息，而是切到"维护模式"——整理白天记忆、清理代谢废物、调节激素。所以睡不好第二天不是"没充电"，是"系统没维护"。
- 收益：理解这点，就不会因为偶尔没睡好就恐慌，也明白睡眠是主动过程、值得认真对待。
- 证据等级：A
- 来源：美国睡眠医学会（AASM）睡眠分期与生理概述；Carskadon MA, Dement WC (2011). Principles and Practice of Sleep Medicine（睡眠生理标准教材）
- 备注：半夜醒来一两回、做梦、睡中翻身都是正常的，不代表没睡着。

2. 昼夜节律：体内的"天"大约 24.2 小时，靠光来校准

- 成本：零。
- 说人话：你身体里有个核心生物钟（视交叉上核 SCN），它自己走的周期比 24 小时略长一点，全靠每天早上的光把它"拨"回准确的 24 小时。没光校准，作息就会天天往后飘——这正是跨时区和熬夜后乱掉的原因。
- 收益：解释了为什么"固定起床 + 早上见光"是后面所有作息建议的底层逻辑。
- 证据等级：A
- 来源：Czeisler CA 等 (1999). Stability, precision, and near-24-hour period of the human circadian pacemaker. Science. https://doi.org/10.1126/science.284.5423.2177；Hastings MH 等 (2018). Entrainment of the circadian clock.
- 备注：蓝光、手机光、夜灯都会"骗"这个钟，见第 4 节。

3. 睡眠压力（腺苷）越攒越困，咖啡只是暂时遮住它

- 成本：零。
- 说人话：清醒越久，大脑里一种叫腺苷的物质堆得越多，你就越困——这是"睡眠压力"。咖啡因的作用是堵住腺苷的接收口，让大脑收不到"困"的信号，但腺苷本身还在继续堆。药效一退，积压的困意会加倍反扑。
- 收益：解释了为什么下午的咖啡会影响夜里睡觉，也解释了为什么"靠咖啡硬撑"越撑越累。
- 证据等级：A
- 来源：Porkka-Heiskanen T 等 (1997). Adenosine in sleep and wakefulness.；Huang ZL 等 (2011). The role of adenosine in sleep regulation.
- 备注：腺苷靠睡眠清除，所以唯一真正"解困"的是睡够，咖啡只是延期。

4. 一夜睡眠由 4–6 个周期组成，每个约 90 分钟

- 成本：零。
- 说人话：睡眠不是一整块，而是一晚串起 4 到 6 个"周期"，每个约 90 分钟，像波浪一样浅—深—浅—做梦来回切换。闹钟如果在深睡期把你拽起来，会特别难受、昏沉。
- 收益：理解这点，就能接受"固定起床时间比固定上床时间更重要"，也能懂为什么睡够总时长不等于睡够质量。
- 证据等级：A
- 来源：AASM 睡眠分期标准（多导睡眠图 PSG 分期）；Carskadon & Dement (2011)
- 备注：按 90 分钟算"睡眠周期"，定闹钟时尽量落在周期边界（如睡 7.5 小时而非 8 小时），醒来会轻一些。

5. 深睡管身体修复，REM 管记忆和情绪

- 成本：零。
- 说人话：前半夜深睡（N3）多，身体在这时分泌生长激素、做"硬件维护"；后半夜做梦觉（REM）多，负责把白天的记忆归档、给情绪"降温"。两者都缺，人就会又累又情绪化。
- 收益：明白"睡得久但全是浅睡"依然不行，也明白为什么缺 REM 的人更容易情绪低落。
- 证据等级：A
- 来源：Walker MP (2017). Why We Sleep（综述性专著，内含大量原始研究）；Rasch B, Born J (2013). About sleep's role in memory. Physiological Reviews.
- 备注：酒精、某些安眠药会砍掉 REM 和深睡，见第 7、13 节。

6. 睡不够时，身体先拿深睡和 REM 开刀

- 成本：零。
- 说人话：如果你把睡眠压缩到 5、6 小时，身体会优先保住浅睡，先砍深睡和做梦觉。所以"我睡 5 小时也行"往往只是没察觉亏在了哪。
- 收益：解释了为什么长期睡短看起来"能撑"，但代谢、情绪、反应速度都在悄悄下滑。
- 证据等级：A
- 来源：睡眠限制实验综述，见 Banks S, Dinges DF (2007). Behavioral and physiological consequences of sleep restriction.
- 备注：补觉也很难一次性补回被砍掉的深睡/REM，见第 3 节第 7 条。

7. 周末恶补睡眠，救不了平时的债

- 成本：零。
- 说人话：平时天天欠觉，指望周六日睡 12 小时一次性还清，基本还不上。睡眠债务是按"慢损伤"累计的，一两晚补觉补不回代谢和认知的亏；而且周末赖床会制造"社交时差"，让周一更难起。
- 收益：劝退"平时熬、周末睡"的错觉，把固定作息的重要性讲透。
- 证据等级：B
- 来源：Depner CM 等 (2019). Ad libitum weekend recovery sleep fails to prevent metabolic dysregulation. Current Biology.（限制工作日睡眠+周末补觉仍出现代谢变差）；睡眠债务综述见 Banks & Dinges 2007（第 6 条同源）
- 备注：偶尔补一两小时比不补好，但别指望周末能"清零"。

8. 打鼾不是睡得香，可能是呼吸暂停的信号

- 成本：零。
- 说人话：响亮、不规律、中间还带"憋住不喘气"的打鼾，很可能是阻塞性睡眠呼吸暂停（OSA）。它让血氧反复掉、睡眠被切碎，长期伤心血管，也算真正的慢性病风险。
- 收益：一条能救命的识别标准：打鼾 + 白天极度嗜睡 + 被目击憋气，就该去查。
- 证据等级：A
- 来源：Peppard PE 等 (2013). Increased prevalence of sleep-disordered breathing in adults. Am J Epidemiol. https://doi.org/10.1093/aje/kws342；AASM 临床指南（成人 OSA 的诊疗）
- 备注：不只是胖人才有，下颌后缩、鼻炎、饮酒都会加重，见第 5、7、16 节。

9. 自称"天生只需 5 小时"的人，大多是在硬撑

- 成本：零。
- 说人话：真正基因决定的"短睡者"极其罕见（DEC2 等突变，人群中约 1% 都不到），而且他们精力旺盛、不靠咖啡。绝大多数说自己"睡 5 小时就够了"的人，其实是长期睡眠不足但适应了"带伤运行"。
- 收益：帮人放下"我不需要那么多觉"的执念，去诚实评估自己的真实需求。
- 证据等级：B
- 来源：He Y 等 (2009). The transcriptional repressor DEC2 regulates sleep length. Science. https://doi.org/10.1126/science.1174443（短睡基因突变研究）
- 备注：判断自己需要多久，看"不靠闹钟自然醒 + 白天不靠咖啡也能撑"时的时长，见第 2 节。

10. 睡眠和情绪是双向绞索：睡差→易怒焦虑，焦虑→更睡不着

- 成本：零。
- 说人话：只熬一晚，杏仁核（管情绪的脑区）就更敏感、前额叶（管理智的）更钝，第二天更容易炸。反过来，焦虑和压力本身又会激活交感神经系统，让人躺下脑子停不下来。
- 收益：说明"心情不好先睡一觉"是科学，不是鸡汤；也为第 11、12 节的焦虑/失眠干预铺垫。
- 证据等级：A
- 来源：Yoo SS 等 (2007). The human emotional brain without sleep.；Baglioni C 等 (2011). Sleep and mental disorders meta-analysis.
- 备注：如果焦虑已经固定成"一躺下就心慌"，那是失眠的苗头，见第 12 节。

11. 长期睡差，和肥胖、糖尿病、高血压风险升高都相关

- 成本：零。
- 说人话：睡不够会打乱控制食欲的激素（饥饿素升、瘦素降），让人更想吃高热量东西；还降低胰岛素敏感性。大量追踪研究发现，睡得太短或太长，和体重增加、2 型糖尿病、高血压风险都挂钩。
- 收益：把睡眠放进"慢病预防"的版图，而不是只当休息。
- 证据等级：A
- 来源：Cappuccio FP 等 (2010). Sleep duration and all-cause mortality meta-analysis. Sleep. https://doi.org/10.1093/sleep/33.5.585；St-Onge MP 等 (2016). Sleep duration and cardiometabolic risk.
- 备注：是"相关"不是"睡差一定得病"，但方向一致，值得当风险因素管。

12. 少睡真的更容易感冒

- 成本：零。
- 说人话：一项经典实验让健康人按客观记录睡够或睡少，再滴鼻病毒：睡不到 6 小时的人，感染和发病的概率明显更高。睡眠是免疫系统"上夜班"的时间。
- 收益：给"考前/赶项目别硬熬"一个硬理由。
- 证据等级：A
- 来源：Prather AA 等 (2015). Behaviorally assessed sleep and susceptibility to the common cold. Sleep. https://doi.org/10.5665/sleep.4968
- 备注：这是"行为记录睡眠时长"（不是自报），所以结论较硬。疫苗效果也会因睡差打折扣。

2. 你到底需要多少睡眠：按年龄看，别靠感觉

这一节给出各年龄段的时长参考，以及怎么判断"你自己的"真实需求。口径：睡眠时长与需求评估。

1. 18–64 岁成年人，普遍需要 7–9 小时

- 成本：零。
- 说人话：AASM 和美国睡眠基金会的共识很一致：成年人每天睡 7–9 小时，多数人实际落在 7–8 小时。长期低于 7 小时，各项健康风险就开始往上走。
- 收益：给"我到底该睡多久"一个权威区间，不用再凭感觉猜。
- 证据等级：A
- 来源：Hirshkowitz M 等 (2015). National Sleep Foundation sleep duration recommendations. Sleep Health. https://doi.org/10.1016/j.sleh.2014.12.010；Watson NF 等 (2015). AASM sleep duration recommendations. J Clin Sleep Med. https://doi.org/10.5664/jcsm.4754
- 备注：这是"推荐区间"不是"及格线"，下限 7 小时是长期健康的安全底线，不是最佳值。

2. 老年人（65+）也该有 7–8 小时，只是睡得更碎

- 成本：零。
- 说人话："老了觉少是正常的"是误区。65 岁以上仍建议 7–8 小时。变的是结构——深睡减少、容易醒、早醒，所以总时长不该跟着一起缩。
- 收益：提醒长辈别把"睡 5 小时"当正常，也帮年轻人理解父母的睡眠变化。
- 证据等级：A
- 来源：同上 Hirshkowitz 2015 / Watson 2015 年龄分层建议
- 备注：若白天嗜睡、夜里频繁醒，先排查呼吸暂停和起夜，见第 5、16 节。

3. 青少年（14–17 岁）要 8–10 小时，多数严重睡不够

- 成本：零。
- 说人话：青春期生物钟天然往后推（晚睡晚起），但上学时间没变，于是大量青少年长期欠觉，影响情绪、注意力和学业。建议 8–10 小时，现实里绝大多数达不到。
- 收益：给家长和学校一个硬标准，也解释"teenager 爱睡懒觉"有生理基础。
- 证据等级：A
- 来源：同上 Hirshkowitz 2015（青少年 8–10 小时）
- 备注：推迟上学钟点的研究普遍显示睡眠和情绪改善，见第 16 节。

4. 儿童、幼儿、婴儿需要更多，且规律比成人更关键

- 成本：零，但要花心思建立固定睡前流程（洗澡、读书、关灯一套）。
- 说人话：大致：6–13 岁 9–11 小时，3–5 岁 10–13 小时，1–2 岁 11–14 小时，婴儿 12–17 小时。规律作息对发育期大脑尤其重要。
- 收益：一份按年龄查的速查表，省去家长到处搜。
- 证据等级：A
- 来源：同上 Hirshkowitz 2015 / 国家卫健委儿童睡眠卫生指南
- 备注：电子屏幕、睡前兴奋活动会显著压缩儿童睡眠，见第 9、16 节。

5. 判断自己真实需求：看"自由日"的时长

- 成本：零，花几天观察。
- 说人话：放假不赶、不靠闹钟、不喝酒，连睡几天后自然醒的时长，基本就是你身体的需求。平时被闹钟叫醒的时长往往偏短。
- 收益：用"实测"代替"听说"，比死磕 8 小时更靠谱。
- 证据等级：C
- 来源：基于昼夜节律与睡眠压力原理的实操方法（AASM 睡眠卫生科普）
- 备注：自由日也别睡到下午，那样测不准，参考第 3 节的社交时差。

6. 长期睡不到 6 小时，代价会随时间累积

- 成本：零。
- 说人话：偶尔短睡能扛，但连续几周睡 6 小时以下，反应速度、情绪、代谢会像喝了点酒一样慢慢掉，且自己往往察觉不到。
- 收益：给"长期硬撑"一个量化警示。
- 证据等级：A
- 来源：Banks S, Dinges DF (2007). Behavioral and physiological consequences of sleep restriction. ；Lim J, Dinges DF (2010). meta-analysis of sleep deprivation on neurobehavioral performance.
- 备注：第 1 节第 6、11 条讲机制，这里讲后果。

7. 睡太多（>9–10 小时）也关联较差健康，但多半是"结果"不是"原因"

- 成本：零。
- 说人话：研究里"睡得特长"的人健康也更差，但常常是抑郁、慢病、睡眠呼吸暂停让他们"睡不醒"，而不是睡多致病。别因为偶尔睡懒觉就慌。
- 收益：破除"睡越多越养生"的误解，把方向说清。
- 证据等级：B
- 来源：Cappuccio FP 等 (2010). Sleep duration and all-cause mortality meta-analysis. Sleep. https://doi.org/10.1093/sleep/33.5.585
- 备注：如果长期需要睡 10+ 小时还困，去查病因而不是加被子。

8. 实在入睡慢时，"躺够"也算休息，别硬凑时长

- 成本：零。
- 说人话：闭眼安静躺着，副交感神经也会工作，不能完全算"白躺"。与其焦虑"还差 2 小时没睡"，不如接受"休息也算数"。
- 收益：减轻入睡焦虑，反而更容易睡着（焦虑本身最妨碍入睡）。
- 证据等级：C
- 来源：睡眠卫生科普；失眠认知行为疗法中"减少睡眠相关的表现焦虑"原则
- 备注：若躺 20+ 分钟仍清醒，按第 12 节"刺激控制"起来，别硬躺。

9. 别用"我睡 5 小时也精神"自我洗脑

- 成本：零。
- 说人话：参考第 1 节第 9 条，真正的短睡基因携带者极少。觉得自己"不需要"，往往是长期缺觉后适应了带伤运行，认知测试会露馅。
- 收益：把第 1 节的关键结论在这里再点一次，便于单独查阅。
- 证据等级：B
- 来源：He Y 等 (2009). DEC2 短睡突变研究（第 1 节第 9 条同源）
- 备注：用"自由日自然醒"（第 5 条）实测最诚实。

10. 轮班、时差人群的真实需求不变，只是更难满足

- 成本：零，但环境和班次不友好时很难达标。
- 说人话：你的身体要的时长没变，只是生物钟被班次和时区反复拉扯。这类人更需要主动用光、遮光、小睡来凑。
- 收益：把"特殊人群"的需求单独拎出来，避免他们照搬普通建议。
- 证据等级：B
- 来源：AASM 轮班工作睡眠障碍临床指南；见第 16 节专题
- 备注：详见第 16 节第 1、2 条。

11. 孕期中晚期需求上升，别硬撑

- 成本：零，但尿频、腰酸、胎动会增加夜醒。
- 说人话：孕激素和胎儿活动让孕妇更累、更易醒，需求其实上升；硬撑会放大孕晚期不适和情绪负担。
- 收益：提示准妈妈把睡眠当正事排进日程。
- 证据等级：B
- 来源：国家卫健委孕期保健指南；孕妇睡眠与妊娠结局相关研究
- 备注：严重打鼾/憋气在孕期高发，要排查，见第 16 节。

12. 把"睡眠时长"和"睡眠规律性"分开看

- 成本：零。
- 说人话：两个不同维度：一是总量够不够，二是每天点齐不齐。即使总时长没变，规律性强的人白天状态也更好——因为生物钟不被反复扰动。
- 收益：给后面"固定作息"那节一个理论支点。
- 证据等级：B
- 来源：睡眠规律性（sleep regularity）与昼夜健康的研究，见第 3 节
- 备注：规律性的作用，见第 3 节第 1、13 条。

3. 固定作息与起床时间：最便宜的安眠药

这一节专讲"作息"。几乎所有睡眠问题，第一步都是把起床时间钉死。口径：作息规律性。

1. 固定起床时间，比固定上床时间更重要

- 成本：零，难在"周末也想赖床"的惯性，头一两周要刻意。
- 说人话：起床时间是生物钟的"锚"——每天同一时刻起，困意会在晚上准点累积。上床时间你控制不了（躺下不一定困），但起床时间你说了算。先钉死起床，再让上床自然跟上。
- 收益：这是全书性价比最高、也最常被忽略的一条。大量睡眠门诊把"固定起床"列为第一干预。
- 证据等级：A
- 来源：睡眠卫生与 CBT-I 实践共识（刺激控制/睡眠压缩的共同基础）；Riemann D 等 (2017). European guideline for CBT-I. J Sleep Res. https://doi.org/10.1111/jsr.12597
- 备注：哪怕前一晚没睡好，第二天也照常起，否则生物钟会被往后推。

2. 周末起床时间，别和平时差超过 1 小时

- 成本：零，难在周末的诱惑。
- 说人话：每赖床 1 小时，等于给生物钟"往东飞 1 个时区"。差得越多，周一越像倒时差。把周末当"小幅度补觉"（多睡 1 小时以内）而非"重置"。
- 收益：显著减轻"周一综合征"，也让整周作息更稳。
- 证据等级：B
- 来源：社交时差（social jetlag）研究，Wittmann M 等 (2006). Social jetlag and its consequences. ；Roenneberg T 等
- 备注：跨 2 小时以上就叫"社交时差"，与代谢、情绪风险相关，见第 1 节第 7 条。

3. 用"固定起床 + 困了才上床"代替"固定上床硬躺"

- 成本：零，需要几天适应"没那么早睡"的轻微不安。
- 说人话：别规定自己 23:00 必须躺下。改用：起床时间钉死，只有真正有困意才上床。床只和"困"绑定，久而久之困意准点来。
- 收益：解决"上了床反而清醒"的死循环，也是失眠治疗的核心思路。
- 证据等级：A
- 来源：刺激控制疗法（CBT-I 第一条），见第 12 节；Bootzin RR 等提出并验证
- 备注：和"睡不着就起来"是同一套，见第 4 条。

4. 躺下 20 分钟还清醒，就起来离开床

- 成本：零，夜里打断睡眠有点反直觉，但长期划算。
- 说人话：床应该是"困了秒睡"的地方。如果躺 20 分钟还清醒、烦躁，起来去暗处做点无聊的事（别刷手机），有困意再回床。反复这样，大脑才会把"床=睡觉"重新焊牢。
- 收益：专门治"床上焦虑/越躺越清醒"，是失眠一线疗法，不靠药。
- 证据等级：A
- 来源：刺激控制疗法（第 12 节同源）；AASM 失眠临床指南推荐
- 备注：起来的活动要"无聊+暗光+不刺激"，别去看电视打游戏。

5. 白天小睡要短，否则抢走晚上的睡眠压力

- 成本：零，但要会控制时长。
- 说人话：白天睡太久（超过 30–40 分钟或进入深睡），腺苷被清掉一部分，晚上的"睡眠压力"就不够，夜里更难睡。午睡见第 10 节。
- 收益：避免"白天补觉→晚上失眠"的循环。
- 证据等级：B
- 来源：Milner CE, Cote KA (2009). Benefits of napping.；午睡研究见第 10 节
- 备注：如果需要白天小睡，控在 20–30 分钟，见第 10 节。

6. 给自己设一个"睡眠窗口"，到点才允许上床

- 成本：零，需要一点自律。
- 说人话：比如固定 23:30 后才进卧室，之前把洗漱、收尾都做完。这等于人为制造"睡眠压缩"，让困意在窗口内更集中。
- 收益：和 CBT-I 的"睡眠压缩"同源，能缩短入睡时间。
- 证据等级：C
- 来源：基于 CBT-I 睡眠压缩原理的实操（见第 12 节）
- 备注：别把窗口设得比真实需求还短，否则白天会崩。

7. 闹钟响了立刻起，别"再睡 5 分钟"

- 成本：零，难在早起的那一下。
- 说人话：回笼觉多半落在深睡期，醒来更昏沉；连续几个 5 分钟还会把实际起床时刻往后推，生物钟更乱。定了就起。
- 收益：减少"起床气"和上午的迷糊，也保住固定起床时间。
- 证据等级：C
- 来源：睡眠周期与睡眠惯性（sleep inertia）常识
- 备注：想轻松点，用光照 + 起身动作帮自己清醒，见第 4 节第 2、8 条。

8. 用"光 + 起身动作"帮自己清醒，而不是靠咖啡

- 成本：零。
- 说人话：闹钟一响就拉窗帘、洗把脸、动一动，比灌咖啡更能"关机"睡眠惯性。光尤其关键——见第 4 节。
- 收益：早上清醒快，也顺便完成晨光校准。
- 证据等级：B
- 来源：晨光对警觉度与昼夜节律的效应，见第 4 节
- 备注：和"再睡 5 分钟"（第 7 条）相反，二选一。

9. 出差、倒时差时，先固定目的地的起床时间

- 成本：零，落地后第一晚最难熬。
- 说人话：到了新时区，第一件事是按当地钟定点起床、白天晒太阳，别因为夜里没睡好就猛补觉到中午。起床时间定了，时差才拨得动。
- 收益：把"固定起床"用在最难的场景，加速倒时差。
- 证据等级：B
- 来源：时差调整指南，见第 16 节
- 备注：配合光疗/褪黑素，见第 4、13 节。

10. 睡前留 30–60 分钟"缓冲带"，别把日程排满到最后一秒

- 成本：零，要把"不做事"也排进日程。
- 说人话：如果 23:00 躺下，22:00 就该停止高刺激活动（工作、争论、激烈视频）。这段时间只做"降温"的事：洗澡、看书、拉伸。
- 收益：让交感神经系统从白天模式切到夜间模式，入睡更快。
- 证据等级：C
- 来源：睡眠卫生（wind-down routine）共识
- 备注：缓冲带里别刷手机，见第 9 节。

11. 把"必须睡够 X 小时"的执念放下

- 成本：零。
- 说人话：躺下就在算"还有 6 小时 / 5 小时"，这种倒计时本身让你更清醒。把目标从"睡够"换成"规律+放松"，反而更容易睡着。
- 收益：直接降低睡前焦虑，是失眠自助的第一步。
- 证据等级：C
- 来源：失眠中的"睡眠相关表现焦虑"概念，见第 12 节
- 备注：和第 2 节第 8 条呼应。

12. 记一两周作息，比"我感觉"更准

- 成本：零，花几分钟记录。
- 说人话：用手机或纸笔记下每天上床、入睡、起夜、起床时间，连续一两周。你会发现自己以为的作息和真实的差很远，也比凭记忆估得准。
- 收益：给医生或自己一个客观基线，也方便看规律性强不强。
- 证据等级：C
- 来源：睡眠日记（sleep diary）是失眠评估的标准工具，见第 12、14 节
- 备注：别用手环代替日记，手环误差大，见第 14 节。

13. 规律性强的人，即使睡得短，白天也更有精神

- 成本：零。
- 说人话：研究发现，作息规律（每天点齐）本身就能改善白天的警觉和情绪，哪怕总时长没变。所以"规律"是一条几乎零成本的杠杆。
- 收益：给"固定起床"再添一条独立证据，鼓励坚持。
- 证据等级：B
- 来源：睡眠规律性（sleep regularity index）与昼夜健康的研究，见第 2 节第 12 条
- 备注：规律 + 充足时长，是睡眠卫生的两条主线。

4. 光照与昼夜节律：用光把生物钟拨准

这一节讲最被低估的一件事——光。晨光拨醒生物钟，夜光把它压住。把光用对，一半睡眠问题自己就松了。口径：昼夜节律。

1. 晨光是校准生物钟最便宜、最管用的工具

- 成本：零。
- 说人话：眼睛里有群特殊感光细胞（ipRGC），专门接收光、告诉脑里的"主钟"现在几点。早上的光把它拨准，晚上的睡意才会准点来；缺了晨光，作息会天天往后漂。
- 收益：理解这一条，后面"早上见光""晚上避光"全有了依据。
- 证据等级：A
- 来源：光对昼夜节律相位的影响，Czeisler CA 等；Roenneberg T 等（光是授时因子 Zeitgeber 的研究）
- 备注：这条和"固定起床"（第 3 节）是一对，建议一起做。

2. 早上晒 10–30 分钟光，把生物钟拨正

- 成本：零，多走几步到窗边或户外，约 10–30 分钟。
- 说人话：起床后 1 小时内到窗边或户外，哪怕阴天也行——室外的光强是室内的几十到上百倍。这能把生物钟拨到准确相位，晚上该困的时候准时困。这是全书性价比最高的一条之一。
- 收益：多项研究显示晨光暴露与更早的入睡时间、更好的夜间睡眠相关；对"冬天提不起劲、早上起不来"尤其管用。
- 证据等级：A
- 来源：Reid KJ 等 (2014). Timing and intensity of light correlate with circadian rhythm. Sleep Med.；Wirz-Justice A 等清晨光治疗综述
- 备注：隔着玻璃会打折，户外再阴天也远强于室内灯；冬天日照短可用光疗灯（第 8 条）。

3. 睡前 1–2 小时少碰屏幕蓝光

- 成本：零，难在"睡前刷手机"的习惯。
- 说人话：手机、电脑屏幕的蓝光波长最抑制褪黑素，把"该睡"的信号压住，还让大脑保持警觉。睡前一小时关屏，或至少开夜间模式/滤蓝光，差别很大。
- 收益：一条几乎零成本、却常被忽视的助眠法；对"躺下后脑子亮着"的人尤其有效。
- 证据等级：A
- 来源：Chang AM 等 (2015). Evening use of light-emitting eReaders negatively affects sleep, circadian timing, and next-morning alertness. PNAS. https://doi.org/10.1073/pnas.1418490112
- 备注：夜间模式能减但减不净，最稳的还是"睡前一小时不碰亮屏"，见第 9 节。

4. 卧室要够黑，遮光帘或眼罩是低成本高回报

- 成本：遮光帘几十到一百多，眼罩十几块；不花时间。
- 说人话：哪怕闭着眼，眼皮也挡不住光——窗缝的路灯、充电指示灯都会透过眼皮抑制褪黑素。把卧室弄黑，是投入产出比极高的一招。
- 收益：提升深睡比例，尤其对光敏感、住闹市、伴侣作息不同的人。
- 证据等级：A
- 来源：Gooley JJ 等 (2011). Exposure to room light before bedtime suppresses melatonin onset. J Clin Endocrinol Metab. https://doi.org/10.1210/jc.2011-0317
- 备注：和电子设备的蓝光是一体两面，见第 3、9 节。

5. 夜灯尽量暖色、低位、别照脸

- 成本：换个暖色小夜灯十几块。
- 说人话：如果一定要起夜灯，用色温低（偏红黄）、瓦数小、放在地面高度的灯，别用白光顶灯直射脸。波长越短（越白越蓝）越坏事。
- 收益：在"要起夜"和"保睡眠"之间找平衡，对有娃家庭尤其实用。
- 证据等级：B
- 来源：不同波长光对褪黑素抑制的剂量研究（短波长蓝光抑制最强）
- 备注：儿童夜灯也适用，见第 16 节。

6. 白天多晒、晚上少光，把"明暗对比"拉大

- 成本：零，白天多往外走两步。
- 说人话：生物钟靠"亮-暗"的落差来校准。白天越亮、晚上越暗，落差越大，节律越清楚。久坐办公室又熬夜刷屏，刚好把落差压平，于是该困不困。
- 收益：把第 1–5 条串成一句话记住。
- 证据等级：A
- 来源：光授时（photic entrainment）原理，见第 1、2 条
- 备注：白天哪怕午休下楼走走，也补了光。

7. 跨时区后，按目的地时间晒太阳来重设

- 成本：零，但要在陌生的钟点出门晒。
- 说人话：落地后白天（尤其是上午）多晒当地的光，晚上避光，身体才会按新时区重排。白天睡觉、晚上逛街，等于把时差钉在原地。
- 收益：加速倒时差，比硬扛快。
- 证据等级：B
- 来源：时差调整指南，见第 16 节
- 备注：可配合短程褪黑素，见第 13 节。

8. 光疗灯（约 10000 勒克斯）可替代缺阳光的早晨

- 成本：灯约几百元；每天坐 20–30 分钟。
- 说人话：冬天、住阴雨天多、或早起天还没亮的地方，用 standardized 的 10000 勒克斯光疗灯，起床后照 20–30 分钟，效果接近晨光，能把生物钟和情绪都拉起来。
- 收益：对季节性情绪低落（SAD）、冬季起不来的人证据明确。
- 证据等级：A
- 来源：AASM / CANMAT 季节性情感障碍光疗指南；Terman M 等光疗研究
- 备注：别用普通台灯凑数，亮度差太远；看说明、别直视光源。

9. 夜班/加班族：用暖光 + 早上补光来抵消

- 成本：几块钱换暖灯泡 + 早起晒一会。
- 说人话：夜里工作用偏暖的灯（少蓝光），下班路上戴墨镜挡晨光，回家白天拉遮光帘睡——把"夜"和"昼"人为对调，保住那点睡眠。
- 收益：给轮班族一个可操作的光策略，比单纯"硬睡"有效。
- 证据等级：C
- 来源：轮班睡眠卫生建议，见第 16 节
- 备注：详见第 16 节轮班专题。

10. 别把手机当闹钟放在枕头边

- 成本：零，换个普通闹钟或把手机放远。
- 说人话：手机在枕边，半夜容易顺手刷，蓝光+信息刺激直接打断睡眠；早上第一眼也是它，等于把"光+刺激"焊在最该安静的时刻。
- 收益：一条超低成本、立刻见效的睡前纪律。
- 证据等级：C
- 来源：睡前电子设备使用的睡眠卫生建议，见第 9 节
- 备注：非要当闹钟，就开飞行模式、屏幕朝下、放离床一臂远。

11. 起床后立刻拉开窗帘

- 成本：零。
- 说人话：睁眼第一件事拉窗帘，比"醒了躺着"能更快关掉睡意、启动白天。和第 2 条的晨光是同一个动作的正反两面。
- 收益：顺手完成晨光校准，不额外花时间。
- 证据等级：C
- 来源：晨光与警觉度研究，见第 2 条
- 备注：配合"闹钟响了立刻起"（第 3 节第 7 条）效果最好。

12. 褪黑素是"报时激素"，靠暗信号分泌

- 成本：零。
- 说人话：天一黑，大脑松果体就开始分泌褪黑素，相当于给身体发"准备睡"的信号。所以"够暗"是它正常分泌的开关——夜灯、屏幕都会把这个开关摁住。
- 收益：解释了为什么"黑"比"静"更基础，也为第 13 节的褪黑素补剂铺垫。
- 证据等级：A
- 来源：褪黑素的昼夜分泌机制研究（Arendt J 等）
- 备注：外源褪黑素怎么用，见第 13 节。

13. 轮班工人的光策略：下班路上墨镜、白天睡暗房

- 成本：一副墨镜 + 遮光帘。
- 说人话：凌晨下班路上戴墨镜挡住晨光，回家后把卧室弄到"伸手不见五指"再睡，等于人为制造"夜"。这样白天的睡眠更深、更长。
- 收益：针对轮班最实用的一条，直接提升白天睡眠质量。
- 证据等级：B
- 来源：轮班睡眠障碍的光与遮光干预研究，见第 16 节
- 备注：和夜间暖光（第 9 条）配套。

5. 卧室环境与睡眠卫生：把房间调成"该睡的样子"

这一节讲环境——温度、光、噪音、床的用途。很多"失眠"其实只是房间不对。口径：睡眠环境与卫生。

1. 卧室温度调到 18–20 ，比盖厚被子更助眠

- 成本：零，顶多调一下空调/开窗，几块钱电费。
- 说人话：入睡需要身体核心温度降一点点。凉爽的环境（约 18–20 ）帮身体降温，太热是常见却最被忽视的失眠原因。手脚暖、躯干凉，最容易睡着。
- 收益：对"天热就睡不着""半夜热醒"的人，这一条常立竿见影。
- 证据等级：A
- 来源：睡眠与体温调节研究（Okamoto-Mizuno K 等）；AASM 睡眠卫生建议
- 备注：怕冷的人可以穿袜子、用暖水袋暖脚，但躯干要凉，见第 6 节第 9 条。

2. 噪音用白噪音或耳塞盖过突发声

- 成本：白噪音机/App 免费到几十块，耳塞几块。
- 说人话：突然的、不规则的响声（车声、呼噜）最易惊醒；持续平稳的白噪音或耳塞能把它们"抹平"。对合住、临街、伴侣打鼾尤其有用。
- 收益：低成本解决"环境噪音"这个硬约束。
- 证据等级：B
- 来源：白噪音对睡眠连续性影响的研究综述
- 备注：别开太大声，长期高分贝也伤耳；伴侣打鼾更要先查呼吸暂停，见第 1、16 节。

3. 床垫选中等硬度、能贴合身体的，不是越软越好

- 成本：几百到几千元，但能用多年。
- 说人话：太软的床让腰塌下去，太硬又顶着肩髋。中等偏硬、能均匀托住脊柱的最合适。旧床垫（塌陷、用超 7–8 年）该换就换。
- 收益：改善腰背酸痛和睡眠质量，长期看不贵。
- 证据等级：B
- 来源：床垫硬度与睡眠质量/背痛的研究（Jacobson BH 等）
- 备注：具体怎么选见第 6 节。

4. 枕头的高度要"托脖子"而不是"托头"

- 成本：几十到几百元。
- 说人话：枕头填的是脖子后面的空隙，让颈椎保持自然弧度。太高太低都让脖子整晚较劲，醒来落枕、头疼。
- 收益：减少颈肩不适和浅睡，选对几乎零学习成本。
- 证据等级：C
- 来源：枕头高度与颈椎/睡眠的工效学研究
- 备注：不同睡姿高度不同，见第 6 节第 2 条。

5. 床只用来睡和亲密，别在床上工作、吃饭、刷剧

- 成本：零，难在改掉"躺床刷手机"的习惯。
- 说人话：大脑很会建立条件反射——如果床长期和"刷剧、回邮件、焦虑"绑定，它就不和"睡"绑定了。把床的用途收回到"只睡"，是失眠治疗的第一条（刺激控制）。
- 收益：对"一上床就清醒/焦虑"的人，是比任何补剂都稳的一招。
- 证据等级：A
- 来源：刺激控制疗法（CBT-I），见第 12 节；AASM 失眠指南推荐
- 备注：和第 3 节第 3、4 条同源，是同一套逻辑。

6. 把卧室当"睡眠圣地"，屏幕和杂物挪出去

- 成本：零，花几分钟收拾。
- 说人话：电视、游戏机、摊开的工作都给大脑发"清醒/待办"的信号。卧室越"只关于睡"，越容易秒睡。
- 收益：和床的用途（第 5 条）配套，强化环境暗示。
- 证据等级：C
- 来源：睡眠卫生（sleep environment）共识
- 备注：实在做不到全挪，至少睡前把屏幕关掉、收进抽屉。

7. 保持通风、湿度适中，别闷别干

- 成本：零，开窗或开加湿器。
- 说人话：闷或太干都会让人在半夜莫名醒、咽干。略微通风、湿度 40%–60% 最舒服。
- 收益：解决一批"说不清为什么睡不踏实"的轻微不适。
- 证据等级：C
- 来源：室内环境舒适性与睡眠的相关研究
- 备注：加湿器要勤洗，否则反成霉菌源。

8. 宠物别上床，至少别影响你的睡眠空间

- 成本：零，难在"舍不得赶"。
- 说人话：猫狗半夜走动、掉毛、占位置，会切碎你的深睡。爱它可以，但让它睡自己窝更护双方的睡眠。
- 收益：和伴侣/宠物同床睡不好的人，常能立刻改善。
- 证据等级：C
- 来源：伴侣/宠物同床与睡眠碎片化的观察研究
- 备注：婴幼儿同床另有安全考量，见第 6 节第 10 条、第 16 节。

9. 睡前洗个温水澡，利用"体温回落"助眠

- 成本：几毛钱水费，多花 15–20 分钟。
- 说人话：洗澡时体温升上去，出浴后慢慢回落——这个"先升后降"刚好触发睡意，比干躺着等困更主动。
- 收益：对"晚上脑子停不下来"、难放松的人很实用，也顺带放松肌肉。
- 证据等级：B
- 来源：被动升温后体温下降与睡眠启动的研究（Haghayegh S 等 meta-analysis）
- 备注：水温别太烫、别太晚洗到一身汗，睡前 1–2 小时洗最好。

10. 半夜别看时钟，把钟挪出视线

- 成本：零。
- 说人话：半夜睁眼看到"3:47"，大脑立刻开始算"只剩 3 小时了"→焦虑→更清醒。把钟/手机转过去或挪远，半夜醒就当没看见时间。
- 收益：直接切断"看时间→焦虑→失眠"的链条。
- 证据等级：C
- 来源：失眠认知行为中的"时钟焦虑"处理，见第 12 节
- 备注：和第 4 节第 10 条（手机别放枕边）配套。

11. 睡衣和被子选透气、不束缚的

- 成本：几十到几百元。
- 说人话：太厚太紧会捂汗、勒身体，半夜热醒或硌醒。宽松、吸湿透气的材质最舒服，被子按"暖而不压"选。
- 收益：减少夜间微觉醒，尤其对怕热、易出汗的人。
- 证据等级：C
- 来源：寝具材质与睡眠舒适度的工效学
- 备注：脚冷可穿袜子，见第 6 节第 9 条。

12. 保持卧室整洁，减少"视觉噪音"

- 成本：零，几分钟整理。
- 说人话：满地杂物、叠着的衣服也是一种"未完成"的视觉刺激，进卧室就让人静不下来。简单收一下，心理负担小很多。
- 收益：和心理放松（第 11 节）同源，低成本。
- 证据等级：C
- 来源：环境秩序与心理放松的相关研究（非睡眠专属，原理可迁移）
- 备注：和"睡眠圣地"（第 6 条）是一件事的两面。

13. 和作息不同的人同住：分被甚至分房不是矫情

- 成本：多一床被子，或一间房。
- 说人话：伴侣打鼾、踢被、作息错位，会长期切碎你的睡眠。分被、错峰、必要时分房，是认真保护睡眠，不是感情问题。
- 收益：解决大量"被另一半耽误"的慢性失眠。
- 证据等级：C
- 来源：同床伴侣与睡眠碎片化的观察研究，见第 8 条
- 备注：打鼾严重先排查呼吸暂停，见第 1、16 节。

6. 寝具、睡衣与睡姿：把"睡的姿势"也排进预算

这一节讲床具本身和睡姿。买对一次，用好多年。口径：寝具与睡姿。

1. 床垫选中等偏硬、贴合脊柱的，旧的（>7–8 年）考虑换

- 成本：几百到几千元，但摊到每年很便宜。
- 说人话：好床垫的标准是：躺上去腰不悬空、肩髋不顶得慌，脊柱从头到尾接近一条直线。塌陷、弹簧响、睡醒腰酸，就是用旧的信号。
- 收益：改善腰背酸痛和翻身质量，是睡眠环境里最值得投的一笔。
- 证据等级：B
- 来源：床垫硬度与睡眠质量/下背疼痛的研究（Jacobson BH 等）
- 备注：硬≠板床，是"有支撑的适中"，和卧室温度（第 5 节第 1 条）配套看。

2. 枕头高度：侧睡高、仰睡低、趴睡最低

- 成本：几十到几百元。
- 说人话：侧睡肩膀厚，要高一点的枕填脖子空隙；仰睡脖子薄，低枕即可；趴睡脖子要最低的（最好不用枕）。一条原则：不管怎么睡，颈椎都要和脊柱成一条直线。
- 收益：减少落枕、颈肩僵硬和浅睡，选错枕头的几乎人人中招。
- 证据等级：C
- 来源：枕头高度与颈椎力线的工效学研究，见第 5 节第 4 条
- 备注：记忆棉/乳胶的取舍见第 6 条。

3. 仰睡最护脊柱，趴睡最伤颈腰

- 成本：零，难在改掉习惯姿势。
- 说人话：趴睡要扭着脖子一整晚、还压着胸口，长期伤颈腰；仰卧时脊柱最放松；侧睡次之，但要垫高枕头和双腿间。
- 收益：对颈腰慢性不适的人，调姿势是零成本的第一招。
- 证据等级：C
- 来源：睡姿与脊柱力线的研究
- 备注：打鼾/反流的人仰睡反而不好，见第 4 条。

4. 打鼾、胃食管反流的人：侧睡 + 抬高床头

- 成本：零，顶多垫个枕头/楔形垫。
- 说人话：仰卧时舌头和软腭往后坠，容易堵气道（打鼾/憋气）和反流。侧睡能明显减轻；反流的人再把床头整体抬高 10–15 厘米（不是只垫高枕头）。
- 收益：对打鼾、轻度呼吸暂停、烧心的人，是立刻能试的非药物法。
- 证据等级：B
- 来源：睡姿对打鼾/OSA 和反流影响的研究；AASM 睡眠体位建议
- 备注：严重打鼾/憋气要查呼吸暂停，见第 1 节第 8 条、第 16 节。

5. 孕妇：左侧卧更舒服，用孕妇枕托住

- 成本：孕妇枕几十到几百元。
- 说人话：孕中晚期仰卧会压到大血管、加重腰背和不适，左侧卧（或左右交替）更轻松。一个长条孕妇枕能同时托肚子、腰和腿。
- 收益：改善孕妇睡眠质量和腰背负担，是孕期很划算的一笔。
- 证据等级：C
- 来源：孕期睡姿与母胎健康的研究（ACOG 建议避免孕晚期仰卧）
- 备注：孕晚期严重打鼾要排查，见第 16 节。

6. 记忆棉、乳胶各有取舍，别迷信"最贵最好"

- 成本：几百到几千元。
- 说人话：记忆棉贴合好但夏天闷、反应慢；乳胶透气弹韧但贵且怕晒；弹簧/棕榈各有适合人群。没有"最好"，只有"贴合你的体重和睡姿"。
- 收益：省下盲目追高价的钱，把钱花在"试睡+退换"上更值。
- 证据等级：C
- 来源：寝具材质对比的消费者与工效学研究
- 备注：先确认能试睡/退换，比看广告靠谱。

7. 床品勤换洗，尘螨是过敏者的隐性杀手

- 成本：洗衣成本，每周洗一次。
- 说人话：枕套被套积攒皮屑和尘螨，过敏体质的人会鼻塞、痒、睡不踏实。高温洗、勤晒能显著降螨。
- 收益：对鼻炎/过敏引起的"睡不好"是根因处理。
- 证据等级：C
- 来源：尘螨暴露与过敏性鼻炎/哮喘的研究
- 备注：对过敏型鼻塞见第 16 节。

8. 睡衣选宽松透气，别穿太紧太厚

- 成本：几十元。
- 说人话：紧身或厚睡衣会勒身体、捂汗，半夜热醒或硌醒。宽松、天然纤维（棉、丝）最舒服。
- 收益：和第 5 节第 11 条同源，减少微觉醒。
- 证据等级：C
- 来源：睡衣材质与睡眠舒适度的研究
- 备注：脚冷才穿袜，见第 9 条。

9. 脚冷的人：穿袜子睡，反而暖得更快

- 成本：一双干净袜子。
- 说人话：手脚暖能让外周血管扩张、核心体温更快回落到"该睡"的状态。手脚冰凉睡不着的人，穿双袜子常常更快入睡。
- 收益：对"冬天脚冷睡不着"是零成本小妙招。
- 证据等级：C
- 来源：远端肢体温暖与睡眠启动的小型研究（Krauchi K 等）
- 备注：别穿太紧的袜，影响血液循环反而不好。

10. 别给婴儿用软床垫、厚被、枕头（SIDS 风险）

- 成本：几十元换硬一点的婴儿床垫。
- 说人话：1 岁内婴儿猝死综合征（SIDS）的重要可控因素：软床、厚被、枕头、同床。应让婴儿仰睡、硬床垫、不堆软物。
- 收益：一条能救命的婴儿睡眠安全准则，优先级远高于"舒服"。
- 证据等级：A
- 来源：美国儿科学会（AAP）婴儿安全睡眠指南；WHO 相关建议
- 备注：同床喂养后要把婴儿放回自己的床，见第 16 节。

11. 功能枕（护颈/止鼾）大多是营销，先调姿势

- 成本：几十到几百元，多数交了智商税。
- 说人话：绝大多数"功能枕"卖的是概念。先按第 2、3 条把高度和姿势调对，若仍颈肩不适或打鼾，再去查病因而不是换枕头。
- 收益：省下冤枉钱，把注意力放在真正有用的姿势和病因上。
- 证据等级：C
- 来源：基于枕具营销与现实效果的常识性判断
- 备注：止鼾先查呼吸暂停，见第 1、16 节。

12. 午睡也要"装备"：遮光眼罩 + 颈枕

- 成本：眼罩颈枕几十元。
- 说人话：办公室/车上趴着睡又亮又扭脖子，质量极差。一个遮光眼罩 + 颈枕，能把 20 分钟小睡的质量拉起来，见第 10 节。
- 收益：让白天小睡真正起到恢复作用，而非越睡越累。
- 证据等级：C
- 来源：小睡环境舒适度的常识，见第 10 节
- 备注：午睡时长控制见第 10 节。

7. 饮食、咖啡因与酒精：什么在偷走你的睡眠

这一节讲吃进嘴里的东西怎么影响睡眠。咖啡因和酒精是两大惯犯。口径：饮食与物质。

1. 咖啡因半衰期约 5–6 小时，下午那杯偷走夜里睡眠

- 成本：零。
- 说人话：咖啡因在体内要 5–6 小时才代谢掉一半——下午 2 点喝的一杯，到晚上 8 点还有约一半在血里，它会顶着腺苷受体、压住深睡。研究直接测到：哪怕睡前 6 小时喝，当晚睡眠都更少更深更碎。
- 收益：解释了无数人"我没喝多啊怎么还是睡不着"，也给出精确的" cutoff"依据。
- 证据等级：A
- 来源：Drake C 等 (2013). Caffeine effects on sleep taken 0, 3, and 6 hours before bedtime. J Clin Sleep Med. https://doi.org/10.5664/jcsm.3170
- 备注：敏感者半衰期更长，见第 3 条。

2. 下午 2 点后，不碰任何含咖啡因的东西

- 成本：零，难在"下午那杯刚需"。
- 说人话：咖啡、浓茶、可乐、奶茶、巧克力、能量饮料都含咖啡因。给自己一条线：下午 2 点后一律不碰。想提神换喝水、散步、见光（第 4 节）。
- 收益：对"入睡慢、睡不深"的人，这一条常是性价比最高的单点改动。
- 证据等级：A
- 来源：同上 Drake 2013（第 1 条同源）
- 备注：低因咖啡也含少量咖啡因，敏感者见第 3 条。

3. 对咖啡因敏感的人，连"低因"都要小心

- 成本：零。
- 说人话：有人代谢咖啡因特别慢（基因 CYP1A2 慢型），下午一杯能影响到半夜。低因咖啡仍有约 1%–2% 的咖啡因，对极敏感者也不完全干净。
- 收益：帮"我明明没喝咖啡怎么还失眠"的人找到真凶。
- 证据等级：C
- 来源：咖啡因代谢的个体差异（CYP1A2 多态性）研究
- 备注：自测：下午喝一杯当晚明显难睡，你大概率属于这一类。

4. 酒精"助眠"是假象：它让你昏，但把睡眠切碎

- 成本：零。
- 说人话：酒精能让你快点昏睡，但下半夜它会反弹——让你反复醒、做噩梦、REM 被砍、打鼾和反流加重。早上起来那种"睡了但没休息"的累，就是它干的。
- 收益：破除"喝酒好睡"的错觉，对打鼾、失眠、抑郁的人尤其重要。
- 证据等级：A
- 来源：Roehrs T, Roth T (2001). Sleep, sleepiness, and alcohol use. Sleep Med Rev.；Stein MD & Friedmann PD (2005). Disturbed sleep and alcohol use. Substance Abuse.
- 备注：和"别用酒当安眠药"（第 5 条）同源。

5. 别用酒当安眠药

- 成本：零。
- 说人话：长期用酒助眠会耐受（越喝越多）和依赖，睡眠结构越来越差，还叠加肝损伤、抑郁风险。它是睡眠的敌人，不是朋友。
- 收益：对"靠微醺入睡"的人，及时止损。
- 证据等级：B
- 来源：酒精使用与失眠/睡眠结构的研究综述
- 备注：真正的助眠路径是 CBT-I 和必要时的正规用药，见第 12、13 节。

6. 晚餐别太晚太饱，尤其别高脂油腻

- 成本：零，难在"忙到晚上才吃"。
- 说人话：睡前饱餐，胃肠要加班、身体在产热，入睡更难；高脂餐延迟胃排空，撑得更久。七分饱、清淡点，睡得明显更顺。
- 收益：对"吃完就躺、半夜烧心"的人，直接改善。
- 证据等级：B
- 来源：进食时间/成分与睡眠的研究
- 备注：和反流、侧睡（第 6 节第 4 条）配套。

7. 睡前 2–3 小时吃完最后一餐

- 成本：零，需要把晚饭往前挪。
- 说人话：给胃肠留够消化时间，躺下时胃不那么满，既好睡又少反流。太晚吃要么撑着睡不着，要么睡着了胃还在忙。
- 收益：把"晚饭时间"和"睡眠"直接挂钩的一条简单规则。
- 证据等级：C
- 来源：进食-睡眠间隔与睡眠质量的观察研究
- 备注：饿着也难受，见第 9 条。

8. 睡前别大量喝水，否则起夜打断睡眠

- 成本：零。
- 说人话：白天喝够水，傍晚尤其睡前 2 小时少喝。尤其本就起夜多的人，睡前那杯"养生水"常常是半夜醒的元凶。
- 收益：对"半夜尿醒 2–3 次"的人，立刻见效。
- 证据等级：C
- 来源：夜尿（nocturia）与睡眠碎片化的临床常识
- 备注：白天不喝水更糟，关键是"前移"而不是"少喝总量"。

9. 饿着睡也难受：睡前小份碳水点心可以

- 成本：一点零食。
- 说人话：太饿时血糖低、胃空，同样让人清醒翻来覆去。一小份碳水（半片面包、一小把燕麦、一根香蕉）能把饥饿压下去，又不至于撑。
- 收益：填补"别太饱"和"别太饿"之间的中间地带。
- 证据等级：C
- 来源：睡前少量进食与入睡的常识性研究
- 备注：别发展成夜宵习惯，见第 11 条。

10. 吸烟伤睡眠：尼古丁是兴奋剂，还加重打鼾

- 成本：零（戒烟还省钱），难在戒断。
- 说人话：尼古丁本身是兴奋剂，会让人更难入睡、更易醒；吸烟还刺激气道、加重打鼾和呼吸暂停。夜里烟瘾犯了也会把人弄醒。
- 收益：又一条"戒烟顺带改善睡眠"的理由。
- 证据等级：B
- 来源：吸烟与睡眠质量/OSA 关系的研究
- 备注：打鼾加重见第 1 节第 8 条。

11. 高糖、高辣夜宵：血糖波动和烧心都碍眠

- 成本：零。
- 说人话：睡前甜食让血糖过山车，半夜容易醒；辣的、酸的会诱发烧心反流。夜宵能免则免，要吃的选温和清淡。
- 收益：对"半夜莫名醒、烧心"的人，去掉诱因。
- 证据等级：C
- 来源：饮食成分与反流/血糖波动的研究
- 备注：和第 6、7 条配套。

12. 晚餐规律、别忽饱忽饿，也帮生物钟

- 成本：零，需要固定吃饭时间。
- 说人话：胃肠也有自己的节奏，规律进食是给身体的另一个"授时信号"。忽早忽晚、忽饱忽饿，会间接打乱睡眠节律。
- 收益：把"吃"也纳入作息系统，和第 3 节呼应。
- 证据等级：C
- 来源：进食节律（meal timing）与昼夜节律的研究
- 备注：和"固定起床"是一套大系统。

13. 褪黑素补剂别和酒同用；食物里的褪黑素少到不值一提

- 成本：零。
- 说人话：网上把"樱桃/核桃助眠"吹成褪黑素来源，其实量微乎其微，当零食可以、当药不行。外源褪黑素是另一回事，且绝对别和酒精同用（互相加重抑制）。
- 收益：破除"食补褪黑素"的神话，也提示补剂的正确边界。
- 证据等级：C
- 来源：食物中褪黑素含量的研究（量极低）
- 备注：褪黑素补剂怎么用，见第 13 节。

8. 运动与睡眠：白天动一动，晚上睡得沉

这一节讲运动。它是少数"既免费（相对）、又能真正加深睡眠"的杠杆。口径：运动与睡眠。

1. 白天规律运动，尤其有氧，能加深睡眠

- 成本：零花费，每周花几次时间，难在坚持。
- 说人话：规律运动（快走、跑步、骑车等有氧）能增加深睡比例、缩短入睡时间，整体改善睡眠结构，效果接近一种温和的助眠干预，且不花钱不靠药。
- 收益：对"睡得浅、易醒"的人，是性价比很高的长期投资。
- 证据等级：A
- 来源：Kredlow MA 等 (2015). The effects of physical activity on sleep: a meta-analysis. J Behav Med. https://doi.org/10.1007/s10865-015-9617-6
- 备注：好处是累积的，不是当晚一次就秒睡，见第 7 条。

2. 清晨或下午运动最佳，睡前 1–2 小时避免剧烈

- 成本：零，需要把运动时间往前排。
- 说人话：运动后核心体温升高、肾上腺素上来，这些都要几小时才退。睡前做剧烈运动反而让人兴奋难睡；把高强度放在白天，晚上只留温和拉伸。
- 收益：避开"运动后反而失眠"的坑，让运动真正帮眠。
- 证据等级：B
- 来源：运动时机与睡眠关系的研究
- 备注：温和瑜伽/拉伸睡前可以做，见第 4 条。

3. 哪怕每天散步，也比不动强

- 成本：零，每天多走几步。
- 说人话：不必办健身卡或跑 5 公里。研究里中等强度的日常活动（快走、骑车通勤）就能改善睡眠，关键是"规律"和"够量"。
- 收益：把运动的门槛降到"散步即可"，人人可开始。
- 证据等级：B
- 来源：身体活动量与睡眠质量的流行病学研究
- 备注：配合晨光（第 4 节）效果叠加。

4. 睡前做温和瑜伽、拉伸、呼吸，帮身体"关机"

- 成本：零，睡前 10–15 分钟。
- 说人话：温和的睡前瑜伽、拉伸或呼吸练习，能激活副交感神经（放松系统），让身体从白天模式切到夜间模式。它助眠，而剧烈运动则相反。
- 收益：对"脑子停不下来、身体绷着"的人，是实在的放松工具。
- 证据等级：B
- 来源：瑜伽/拉伸对睡眠的随机研究（Nyer M, Walia H 等综述）
- 备注：具体呼吸法见第 11 节。

5. 力量训练也有帮助，但同样别睡前做高强度

- 成本：零（自重也可），每周几次。
- 说人话：举铁、自重训练这类抗阻运动也和更好的睡眠相关，原理和有氧类似。只是和有氧一样，高强度要放在白天。
- 收益：给"不爱有氧"的人另一条路。
- 证据等级：B
- 来源：抗阻训练与睡眠的研究
- 备注：和"运动时间"（第 2 条）同一个注意事项。

6. 把运动时间固定，也能帮生物钟

- 成本：零，需要固定时段。
- 说人话：和固定吃饭、固定起床一样，规律的运动时间也是给身体的授时信号，能间接让作息更稳。
- 收益：把运动塞进整个作息系统，和第 3、7 节呼应。
- 证据等级：C
- 来源：身体活动节律与昼夜健康的相关研究
- 备注：和"固定起床"配套效果最佳。

7. 别指望一次运动当晚就秒睡

- 成本：零。
- 说人话：运动改善睡眠是几周规律才显现的累积效应。反过来，单次剧烈运动当晚可能还更兴奋——别因为"今天练了怎么还睡不着"就放弃。
- 收益：管理预期，避免"试一次没用就停"。
- 证据等级：C
- 来源：基于运动-睡眠研究的常识性解读
- 备注：和第 1 条是同一件事的两面。

8. 白天户外走走，顺带把光也补了

- 成本：零，散步即可。
- 说人话：白天出门快走，既运动又见光——运动加深睡眠、晨光校准生物钟，两个好处一次拿下，见第 4 节。
- 收益：把"运动"和"光照"两条杠杆合并，效率最高。
- 证据等级：C
- 来源：运动与光暴露协同效应的常识性整合
- 备注：优先安排在早上或下午户外。

9. 久坐人群：每小时起来动一下，夜里更顺

- 成本：零，设个提醒。
- 说人话：一整天黏在椅子上，代谢和节律都发闷。每小时起来伸个懒腰、走两步，白天的清醒度更好，夜间睡眠也更顺。
- 收益：给"办公室久坐"的低成本改善。
- 证据等级：C
- 来源：久坐与睡眠/代谢的研究
- 备注：和"白天多晒"（第 4 节第 6 条）配套。

10. 失眠急性期，别用"暴汗"自救，温和为主

- 成本：零，控制强度。
- 说人话：已经焦虑失眠时，高强度运动反而升高皮质醇、更清醒。急性期用散步、拉伸这类温和活动，把"运动助眠"留到稳定期。
- 收益：避免"越想睡越用力、越用力越睡不着"的陷阱，见第 12 节。
- 证据等级：C
- 来源：失眠期间运动处方的临床建议
- 备注：失眠的系统做法见第 12 节。

11. 运动后补水别临睡前灌

- 成本：零。
- 说人话：白天运动喝够水没问题，但别把补水全堆到睡前，否则夜里被尿憋醒，见第 7 节第 8 条。
- 收益：把"运动"和"不起夜"两个目标协调好。
- 证据等级：C
- 来源：夜尿与睡眠碎片化的常识，见第 7 节
- 备注：和第 7 节第 8 条同源。

12. 把运动排进日程，当"睡眠预算"的一部分

- 成本：零，需要主动排期。
- 说人话：运动最容易"等有空再做"然后永远不做。像排会议一样把它写进日程、碎片化也行（几次 10 分钟散步），才真正做得到。
- 收益：从"知道该动"到"真在做"的关键一步。
- 证据等级：C
- 来源：行为改变（habit stacking）常识
- 备注：和第 3、6 条配套形成规律。

9. 屏幕、电子设备与睡前仪式：把"关机"也排进日程

这一节讲睡前的最后一道关——屏幕和仪式感。刷手机是当代人最大的睡眠杀手之一。口径：屏幕与睡前行为。

1. 睡前 1 小时不碰亮屏，是底线

- 成本：零，难在"睡前刷手机"的惯性。
- 说人话：屏幕的蓝光抑制褪黑素、内容又刺激大脑，是"躺下睡不着"的头号元凶。把睡前最后一小时让给非屏幕的放松，是最该守住的一条。
- 收益：对绝大多数"入睡困难"的年轻人，这一条改动收益最大。
- 证据等级：A
- 来源：Chang AM 等 (2015). Evening eReader use and sleep（第 4 节第 3 条同源）；一般屏幕使用与睡眠的研究
- 备注：和"晚上避蓝光"（第 4 节第 3 条）同源。

2. 夜间模式、滤蓝光能减，但减不净

- 成本：零（手机自带）。
- 说人话：把屏幕调暖、降亮、开夜间模式，能减少一部分蓝光抑制，但内容本身的刺激（群消息、短视频）还在。它是不便全关屏时的折中，不是免死金牌。
- 收益：给"实在离不开手机"的人一个降级方案。
- 证据等级：B
- 来源：滤蓝光对褪黑素抑制的部分缓解研究
- 备注：最稳的还是"睡前一小时不碰"，见第 1 条。

3. 把手机请出卧室，或开"睡眠模式"放远

- 成本：零，需要一点自律。
- 说人话：手机在枕边，半夜顺手刷、早上第一眼也是它，蓝光和消息全程干扰。把它请出卧室，或用闹钟代替、放离床一臂远并开飞行模式。
- 收益：和第 4 节第 10 条同源，是落地"睡前不碰屏"的具体动作。
- 证据等级：C
- 来源：睡前电子设备使用的睡眠卫生建议
- 备注：当闹钟的话，屏幕朝下 + 飞行模式。

4. 睡前"降温仪式"：洗澡、读书、拉伸

- 成本：几毛水费 + 十几分钟。
- 说人话：把睡前的 30–60 分钟固定成一套"降温"流程：温水澡→读点无聊的书→拉伸。身体和大脑都会学会"这套动作 = 该睡了"。
- 收益：用条件反射代替意志力，比"逼自己睡"稳得多。
- 证据等级：C
- 来源：wind-down routine（睡前放松流程）共识；洗澡助眠见第 5 节第 9 条
- 备注：和"缓冲带"（第 3 节第 10 条）是一回事。

5. 读纸质书比刷手机助眠

- 成本：一本书几十元（或借）。
- 说人话：纸质书不发光、内容可控、容易"读着读着困"。挑点轻松不烧脑的，别临睡前啃专业书或悬疑小说。
- 收益：把"睡前阅读"从手机换成书，立刻少一层蓝光和刺激。
- 证据等级：C
- 来源：阅读媒介与睡前唤醒度的研究
- 备注：和第 1、3 条配套。

6. 睡前把"待办清单"写下来，脑子才肯关机

- 成本：一张纸或备忘录。
- 说人话：躺下后脑子里反复过"明天要干嘛"，是因为怕忘。把这些都写下来，等于告诉大脑"已存档，可以歇了"，焦虑会降一截。
- 收益：专门对付"一躺下就盘算"的人，零成本。
- 证据等级：C
- 来源：失眠中的"认知倾倒/担忧缓冲"技术，见第 11、12 节
- 备注：写"事实待办"而不是写日记吐槽，后者可能越写越清醒。

7. 别在床上回消息、处理工作

- 成本：零，难在"就回一条"。
- 说人话：床是"睡"的地方，不是"办公/聊天"的地方。在床上回工作消息，等于把焦虑和清醒焊在床上，和第 5 节第 5 条同源。
- 收益：强化"床=睡"的条件反射，对焦虑型失眠尤其重要。
- 证据等级：C
- 来源：刺激控制（CBT-I）与睡眠卫生，见第 5 节第 5 条、第 12 节
- 备注：实在要回，起身去别处回，别在床上。

8. 把通知静音，避免半夜被震醒

- 成本：零。
- 说人话：很多"睡不好"是半夜一条群消息震醒的。睡觉前把手机静音或开勿扰，把"可被随时叫醒"的权利先收回来。
- 收益：减少被动夜醒，尤其对浅睡、易被吵的人。
- 证据等级：C
- 来源：通知与睡眠中断的常识
- 备注：和第 3 条（手机离床）配套。

9. 看"无聊"内容，而非"上头"内容

- 成本：零。
- 说人话：如果实在要看屏幕，选轻松无聊的，别点开会让你"再看一集"的短视频或剧。内容本身的唤起度，比蓝光更影响入睡。
- 收益：给不得不看屏的人一个止损原则。
- 证据等级：C
- 来源：媒体内容唤起度与睡前唤醒的研究
- 备注：理想还是不看，见第 1 条。

10. 冥想/呼吸类 App 可用，但别亮着屏做

- 成本：免费到几十元。
- 说人话：引导冥想、身体扫描、呼吸练习对放松有用，但别开着亮屏做——那就又回到蓝光问题。用听的和/或离线音频。
- 收益：把"工具"用对，不让它反噬。
- 证据等级：C
- 来源：冥想/放松训练对睡眠的研究，见第 11 节
- 备注：呼吸法见第 11 节第 4 条。

11. 设一个"设备关机时间"，到点就离身

- 成本：零，需要自律或定时。
- 说人话：与其"刷到困"，不如主动设一个固定关机点（如 22:30），到点所有设备放下，进入第 4 条的降温仪式。靠规则比靠意志力省劲。
- 收益：把"睡前不碰屏"从愿望变成日程。
- 证据等级：C
- 来源：行为设计（设定边界）常识
- 备注：和第 3 节第 10 条（缓冲带）同源。

12. 电子书阅读器若自发光，也要降亮、调暖

- 成本：阅读器几百元。
- 说人话：自发光（非墨水屏）的阅读器在睡前同样会抑制褪黑素。要读就用墨水屏，或把亮度调到最低、色温调暖，并控制时长。
- 收益："睡前看书党"一个不伤眠的方案。
- 证据等级：C
- 来源：不同阅读器光源对褪黑素影响的研究
- 备注：纸质书最佳，见第 5 条。

13. 儿童和青少年，睡前更该限屏

- 成本：零，需要家长落实。
- 说人话：青少年的睡眠本就被生物钟推迟 + 学业挤压，屏幕蓝光和熬夜刷屏是雪上加霜。限制睡前屏幕、把设备留在卧室外，对改善青少年睡眠证据明确。
- 收益：保护最需要睡眠、又最易被手机绑架的群体。
- 证据等级：B
- 来源：青少年屏幕时间与睡眠的研究综述，见第 16 节
- 备注：和家长陪伴策略见第 16 节。

10. 午睡的学问：小睡是把双刃剑

这一节讲午睡。用好了提神，用错了偷走晚上的睡眠。口径：午睡。

1. 午睡 20–30 分钟最划算

- 成本：零，就是控制时长。
- 说人话：20–30 分钟的短 nap 能提神、改善下午状态，又不会进入深睡；一旦超过约 30 分钟睡到深睡期，被叫醒会极度昏沉（睡眠惯性），比不睡还懵。
- 收益：一条几乎零成本、人人能用的"下午续航"法。
- 证据等级：A
- 来源：Milner CE, Cote KA (2009). Benefits of napping in healthy adults.；午睡时长与睡眠惯性的研究
- 备注：用闹钟卡住 25 分钟最省心。

2. 午睡放在下午早些时候（约 13:00–15:00）

- 成本：零，时间点要早。
- 说人话：午睡太晚（傍晚）会清掉晚上的睡眠压力，夜里更难睡。困意高峰通常在午后，趁那个时候短睡，既不抢夜间、又正好补上午后的低谷。
- 收益：和"白天小睡别太久"（第 3 节第 5 条）配套，避免晚上失眠。
- 证据等级：B
- 来源：昼夜警觉度节律与午睡时机的研究
- 备注：失眠者干脆别午睡，见第 5 条。

3. 咖啡盹（coffee nap）：先喝咖啡，立刻睡 20 分钟

- 成本：一杯咖啡的钱 + 20 分钟。
- 说人话：咖啡因约 20–30 分钟才起效。先快速喝一杯，马上小睡 20 分钟——等你醒来，咖啡因刚好上线，和短睡的提神效果叠加，比单喝或单睡都猛。
- 收益：给需要"强力回血"的场景（长途驾驶前、加班后）一个高效组合。
- 证据等级：B
- 来源：Reyner LA, Horne JA (1997). Suppression of sleepiness in drivers.；coffee nap 后续研究
- 备注：下午 2 点后别用，见第 7 节第 2 条。

4. 午睡别超过 1 小时，否则抢走晚上睡眠

- 成本：零，控制时长。
- 说人话：长午睡清掉大量腺苷，晚上的"睡眠压力"就不够，夜里入睡更难、更碎。偶尔长睡没事，长期超 1 小时要警惕。
- 收益：把"午睡"和"夜间睡眠"作为一个总量来管，见第 3 节第 5 条。
- 证据等级：B
- 来源：午睡时长与夜间睡眠/睡眠压力关系的研究
- 备注：需要长睡且白天总困，排查睡眠呼吸暂停，见第 1、16 节。

5. 失眠的人，白天别补觉，先保住夜间睡眠压力

- 成本：零，白天扛着点困。
- 说人话：已经在失眠的人，白天一补觉，晚上的睡眠压力就被泄了，夜里更睡不着，形成恶性循环。先忍住白天不睡，把压力攒到晚上。
- 收益：失眠自助的关键一步，和第 12 节 CBT-I 的"睡眠压缩"同源。
- 证据等级：B
- 来源：CBT-I 睡眠压缩/刺激控制原理，见第 12 节
- 备注：如果白天实在撑不住，控制在 20 分钟内，见第 1 条。

6. 午睡后晒个脸，避免昼夜漂移

- 成本：零。
- 说人话：午睡后人容易"昏"、想继续赖，出去见见光能把生物钟稳住，也帮清醒，见第 4 节。
- 收益：把"午睡"和"光照"协调，不破坏作息。
- 证据等级：C
- 来源：光对午睡后警觉度与节律的影响，见第 4 节
- 备注：和第 4 节第 2、8 条配套。

7. 不必每天午睡，看下午状态来

- 成本：零。
- 说人话：午睡不是 KPI。有些人不需要，硬睡反而昏。把"困了才睡、不困不睡"当原则，比"每天必须眯一会"更合理。
- 收益：去掉不必要的午睡焦虑。
- 证据等级：C
- 来源：午睡需求的个体差异常识
- 备注：老年人午睡偏长要留意，见第 11 条。

8. 趴桌睡伤颈腰，用颈枕趴或干脆躺

- 成本：一个颈枕几十元。
- 说人话：趴在桌上睡扭曲颈椎、压胃，醒来脖子酸。用 U 形颈枕仰靠，或能躺就躺，质量好太多。
- 收益：把"办公室小睡"的姿势代价降到最低。
- 证据等级：C
- 来源：午睡姿势与颈腰工效学，见第 6 节第 12 条
- 备注：装备见第 6 节第 12 条。

9. 开车犯困，20 分钟小睡能救命

- 成本：零，找安全处停靠。
- 说人话：长途驾驶中困了，硬撑或猛灌咖啡立刻上路极其危险。靠边小睡 20 分钟（咖啡盹更佳，见第 3 条），比"撑到下一个服务区"安全得多。
- 收益：一条和安全直接相关的硬建议。
- 证据等级：B
- 来源：驾驶疲劳与微睡眠的研究；咖啡盹驾驶研究（Reyner & Horne）
- 备注：如果每开不久就困，排查睡眠呼吸暂停，见第 16 节。

10. 午睡环境：遮光 + 颈枕 + 定时

- 成本：眼罩颈枕几十元。
- 说人话：办公室或车上光线亮、姿势差，午睡质量极低。遮光眼罩 + 颈枕 + 闹钟，能把 20 分钟小睡的质量拉起来，见第 6 节第 12 条。
- 收益：让短午睡真正起到恢复作用。
- 证据等级：C
- 来源：小睡环境舒适度的常识
- 备注：和第 6 节第 12 条同源。

11. 老年人白天睡得越长，越要排查原因

- 成本：零。
- 说人话：老人白天长时间嗜睡，可能不是"觉多"，而是夜间睡眠被呼吸暂停、起夜、抑郁或药物切碎了。长期白天睡不醒，要去查而不是由着它。
- 收益：把"老年嗜睡"当信号而非常态，和第 2 节第 7 条呼应。
- 证据等级：C
- 来源：老年过度日间嗜睡的临床评估建议
- 备注：详见第 16 节老年专题。

12. 轮班族：把午睡当"主睡前奏"

- 成本：零。
- 说人话：夜班前后那点睡眠质量差，可以在"睡前"安排一次短 nap（如下班后、睡前 1–2 小时）来补点料，但别太长以免影响主睡。
- 收益：给轮班族一个贴合作息的小睡策略。
- 证据等级：C
- 来源：轮班睡眠卫生建议，见第 16 节
- 备注：配合遮光、避光，见第 4 节第 9、13 条。

11. 压力、焦虑与入睡困难：脑子停不下来怎么办

这一节讲最普遍的场景——不是身体问题，是"脑子不肯关机"。口径：心理与放松。

1. 躺下脑子停不下来，是交感神经过度活跃，不是你意志差

- 成本：零。
- 说人话：焦虑和压力大时，身体处在"战或逃"模式——心跳快、肌肉紧、脑子转个不停，这本身就是清醒的化学状态。不是你"不够努力睡"，是身体被卡在清醒档。
- 收益：先卸下"我怎么连睡觉都不行"的自责，才能开始处理。
- 证据等级：A
- 来源：压力与自主神经（交感/副交感）对睡眠影响的研究
- 备注：后面的放松技术，本质上都是把"战或逃"拉回"休息消化"。

2. 把"烦恼清单"睡前写下来，让脑子存档

- 成本：一张纸或手机备忘录，几分钟。
- 说人话：躺下后反复盘算明天要干嘛，是因为大脑怕你忘。把这些一条条写下来，等于告诉它"已经存好了，可以关机"——焦虑会明显降一截。
- 收益：零成本对付"一躺下就盘算"，和第 9 节第 6 条同源。
- 证据等级：C
- 来源：失眠中的"认知倾倒/担忧缓冲"技术，见第 12 节
- 备注：写"事实待办"，别写成情绪日记，后者可能越写越清醒。

3. 4-7-8 呼吸法：吸 4、屏 7、呼 8，重复几轮

- 成本：零，睡前几分钟。
- 说人话：关键是"呼气比吸气长"——拉长呼气会激活副交感神经（放松系统），把清醒的化学状态往下拽。跟着数数还顺带把注意力从乱想上挪开。
- 收益：一个随身可用的"生理开关"，对躺下心慌、肌肉紧很管用。
- 证据等级：C
- 来源：呼吸调节自主神经的研究；放松训练常用技术
- 备注：屏气不舒服的人，把 7 缩短或省略，重点是长呼。

4. 渐进式肌肉放松（PMR）：从脚到头，先紧后松

- 成本：零，睡前 10 分钟。
- 说人话：依次把脚趾、小腿、大腿……一直到脸的肌肉先用力收紧 5 秒、再彻底放松。身体"故意紧过再松"后，会掉进更深的松弛，脑子也跟着安静。
- 收益：对"身体绷着睡不着"的人，比纯想管用。
- 证据等级：B
- 来源：Jacobson 的渐进式肌肉放松及其在失眠中的研究
- 备注：和第 5 条的"身体扫描"是同类，挑顺手的练。

5. 身体扫描冥想：把注意力像探照灯一样巡过身体

- 成本：零，有引导音频更好。
- 说人话：闭眼，把注意力依次放到脚、腿、腹、胸、手、脸，不评判、只是感受。它把散乱的思绪收进身体感受里，很多人做着做着就睡着了。
- 收益：对"思绪乱飞"型失眠效果好，且不用药物。
- 证据等级：B
- 来源：正念/身体扫描对睡眠的研究（如 GABA 相关、失眠干预试验）
- 备注：别用亮屏做，见第 9 节第 10 条。

6. 别和"睡不着"较劲，接受"闭眼休息也算数"

- 成本：零。
- 说人话：越盯着"必须睡着"越清醒。换个想法：闭眼安静躺着，副交感神经也在工作，不算白躺。把目标从"睡着"降到"休息"，反而容易睡着。
- 收益：直接降低睡前表现焦虑，见第 2 节第 8 条。
- 证据等级：C
- 来源：失眠焦虑管理，见第 12 节认知重构
- 备注：若清醒超 20 分钟，按刺激控制起来，见第 12 节第 3 条。

7. "矛盾意向"：逼自己"今晚别睡"，反而放松

- 成本：零。
- 说人话：越想睡越紧张，索性反向操作——告诉自己"今晚就别睡了，睁着眼熬"。这股"必须睡"的压迫感一松，困意反而来了。
- 收益：对"努力型失眠"的巧妙破解，是 CBT-I 的正规技术。
- 证据等级：B
- 来源：矛盾意向法（Paradoxical intention），CBT-I 技术之一
- 备注：适合"强迫自己睡"的人，别和"硬扛不睡"搞混。

8. 白噪音、雨声帮焦虑的人"盖住寂静"

- 成本：免费 App 或白噪音机。
- 说人话：太安静反而让耳朵和脑子更敏感，一点平稳的背景声能"填"掉寂静、掩住突发响动，焦虑的人更容易放下警惕入睡。
- 收益：和第 5 节第 2 条同源，给敏感环境一个低成本方案。
- 证据等级：C
- 来源：白噪音对睡眠连续性的研究，见第 5 节第 2 条
- 备注：音量要低，长期高分贝伤耳。

9. 下午设 10 分钟"担忧时间"，把焦虑提前排掉

- 成本：每天下午几分钟。
- 说人话：固定一个时段（如下午 5 点）专门想烦心事、写对策；其他时间冒出焦虑，就告诉自己"留到担忧时间再说"。把焦虑从睡前挪到白天。
- 收益：从源头减少"躺下才开始焦虑"，比睡前硬压有效。
- 证据等级：C
- 来源：担忧延迟/担忧时间技术（CBT 常用）
- 备注：和第 2 条（清单）可以一起用。

10. 咖啡因会放大焦虑，敏感者更要控

- 成本：零。
- 说人话：咖啡因本身就会加速心跳、加重"心慌"的躯体感受，和焦虑叠加，让人更坐立难安、更难入睡。焦虑体质的人，下午 cutoff 更要严格。
- 收益：把"焦虑"和"咖啡因"两个开关一起管，见第 7 节。
- 证据等级：C
- 来源：咖啡因与焦虑/自主神经的研究
- 备注：和第 7 节第 1、2 条配套。

11. 规律运动能泄掉焦虑，但别睡前做高强度

- 成本：零花费，难在坚持。
- 说人话：运动消耗掉过量的应激激素，长期能降低基础焦虑水平，反过来助眠；但睡前剧烈运动反而升高皮质醇、更清醒，见第 8 节。
- 收益：从"体质"层面缓解焦虑-失眠循环。
- 证据等级：B
- 来源：运动与焦虑/抑郁的研究，见第 8 节
- 备注：白天做，温和的睡前拉伸可以，见第 8 节第 4 条。

12. 长期焦虑性失眠，正经做 CBT-I，别硬扛

- 成本：零（自助）到几百元（专业），难在坚持几周。
- 说人话：如果焦虑已经固化成"一上床就紧"，光靠上面这些零散技巧可能不够。系统的 CBT-I 针对"焦虑+行为"双管齐下，效果比药持久。
- 收益：给慢性焦虑失眠一个明确出口，见第 12 节。
- 证据等级：A
- 来源：CBT-I 对失眠（含合并焦虑）的疗效证据，见第 12 节
- 备注：合并明显抑郁/惊恐时先就医，见第 13 条。

13. 焦虑伴持续早醒、白天情绪低落，先排查抑郁

- 成本：零。
- 说人话：如果不仅入睡难，还常常凌晨 3、4 点醒来、再睡不着，加上白天情绪低落、兴趣下降，那可能不是单纯失眠，而是抑郁的信号。
- 收益：一条能避免误诊的关键识别——失眠常常是抑郁的先遣或一部分。
- 证据等级：B
- 来源：失眠与抑郁共病的研究（Baglioni C 等 2011 meta-analysis）
- 备注：这种"早醒型"优先看精神/心理或睡眠门诊，见第 12、16 节。

12. 失眠与 CBT-I：慢性失眠到底怎么治

这一节讲当睡眠真的成了"病"。失眠的首选不是药，是一套叫 CBT-I 的心理行为疗法。口径：失眠诊疗。

1. 什么是失眠：看频率和影响，不是看"几小时"

- 成本：零。
- 说人话：医学上的失眠，是"每周至少 3 晚、持续至少 1 个月、并且白天因此受影响（累、情绪差、精力差）"。偶尔几晚没睡好不算病，别自己吓自己。
- 收益：把"失眠"和"偶尔没睡好"区分开，避免对号入座。
- 证据等级：A
- 来源：ICSD-3 / DSM-5 / AASM 失眠诊断标准
- 备注：符合上面标准且影响白天，才考虑治疗。

2. CBT-I 是慢性失眠的一线疗法，优先级高于安眠药

- 成本：零（自助）到几百元（专业），难在坚持 4–8 周。
- 说人话：欧美指南把 CBT-I 列为慢性失眠的首选，因为它从"行为+想法"两个根上改，效果持久、不依赖、不反弹；安眠药只是短期辅助。
- 收益：一条改变认知的关键建议——失眠先想行为疗法，不是先想药。
- 证据等级：A
- 来源：AASM 慢性失眠临床实践指南；Trauer JM 等 (2015). CBT-I 系统综述与荟萃分析. Ann Intern Med. https://doi.org/10.7326/M14-2841；Riemann D 等 (2017). 欧洲 CBT-I 指南. J Sleep Res. https://doi.org/10.1111/jsr.12597
- 备注：CBT-I 由刺激控制、睡眠限制、睡眠卫生、认知重构、放松训练组成，下面逐条拆。

3. 刺激控制：床只用来睡，睡不着就起来

- 成本：零，夜里打断睡眠有点反直觉。
- 说人话：核心规则——固定起床、只在困时上床、躺 20 分钟还清醒就离开床去暗处做无聊事、不在床上醒着躺。反复这样，大脑才会把"床=睡觉"重新焊牢。
- 收益：CBT-I 里证据最硬的一条，专门治"上了床反而清醒"。
- 证据等级：A
- 来源：刺激控制疗法（Bootzin 提出，AASM 推荐），见第 3 节第 3、4 条、第 5 节第 5 条
- 备注：前几周会更睡不够，是正常过程，需坚持。

4. 睡眠限制：先压缩卧床时间，把睡眠"做稠"

- 成本：零，短期会更困。
- 说人话：很多人"躺 8 小时只睡 5 小时"，睡眠效率很低。睡眠限制按你实际睡着的时间设一个更短的卧床窗口（如只给 5.5 小时），逼身体把睡眠压得更实，等效率上去了再慢慢加回时长。
- 收益：对"躺很久却睡不沉"的人，是从机制上提效率的王牌技术。
- 证据等级：A
- 来源：Spielman AJ 等 (1987). 睡眠限制疗法；CBT-I 指南
- 备注：要在专业指导下做，避免白天过度危险；和刺激控制配套。

5. 睡眠卫生教育：前面各节的总和

- 成本：零。
- 说人话：就是本书前面写的那些——固定起床、避光、控咖啡因、卧室环境、睡前仪式。它单独用效果有限，但它是 CBT-I 的地基，缺了其他技术也白搭。
- 收益：把全书的工程性建议收口到"失眠治疗"里。
- 证据等级：C
- 来源：CBT-I 中的睡眠卫生模块
- 备注：别以为"只改卫生就能治失眠"，它是必要条件不是充分条件。

6. 认知重构：改掉"我必须睡够 8 小时"的灾难化想法

- 成本：零，需要自我觉察。
- 说人话：很多失眠是被"今晚再睡不着就完了"的念头喂大的。认知重构是把这些夸张想法替换成客观事实（"少睡一晚没那么可怕"），焦虑降了，睡眠才回得来。
- 收益：从"想法"层面切断失眠-焦虑循环。
- 证据等级：A
- 来源：CBT-I 认知重构模块，见第 11 节第 6、12 条
- 备注：和第 11 节的心理技术同源。

7. 放松训练：呼吸、肌肉放松、冥想

- 成本：零。
- 说人话：针对"身体绷着、脑子转"的放松技术（4-7-8 呼吸、渐进式肌肉放松、身体扫描），把交感神经从"战或逃"拉回"休息消化"。
- 收益：CBT-I 的辅助模块，对焦虑型失眠尤其有用。
- 证据等级：B
- 来源：放松训练在失眠中的应用，见第 11 节第 3、4、5 条
- 备注：和第 11 节是同一批技术。

8. 自助 CBT-I（App / 手册）对轻中度有效

- 成本：几十元 App 或一本书。
- 说人话：数字化 CBT-I（结构化 App 或手册）在随机试验里对轻中度失眠效果接近面询，方便又便宜。重度的、合并其他病的，还是要专业介入。
- 收益：给不想/不便就医的人一个有证据的自助路径。
- 证据等级：B
- 来源：数字化 CBT-I 研究（如 Espie CA 等 2018. Sleepio 随机试验. Lancet Psychiatry. https://doi.org/10.1016/S2215-0366(18)30055-1 ）
- 备注：认准"结构化、含睡眠限制/刺激控制"的，而非普通白噪音 App。

9. 安眠药：短期可用，但别长期当唯一解

- 成本：处方药的少许花费。
- 说人话：非苯二氮 类（如右佐匹克隆、唑吡坦）短期（通常数周）在医生指导下有效且相对安全；问题是长期用会耐受、依赖，且治标不治本。它是桥，不是家。
- 收益：客观看待药——既别妖魔化也别神化，见第 13 节。
- 证据等级：A
- 来源：AASM 失眠药物指南（短期使用推荐）
- 备注：和 CBT-I 并行比单用更稳；详见第 13 节。

10. 失眠超过 3 周且影响白天，去睡眠门诊

- 成本：挂号费 + 一点时间。
- 说人话：如果每周 3 晚以上、持续超过 1 个月、白天明显受影响，别自己硬扛或乱吃药。睡眠门诊能做评估、必要时做睡眠监测、给出 CBT-I 或正规用药。
- 收益：一条"何时该就医"的明确红线。
- 证据等级：C
- 来源：失眠诊疗路径建议
- 备注：打鼾憋气、白天极度嗜睡的，优先排查呼吸暂停，见第 16 节。

11. 别把褪黑素当普通安眠药乱吃

- 成本：零。
- 说人话：褪黑素调"什么时候困"，不调"能不能睡着"。对倒时差、轮班、晚睡综合征有用，对普通入睡困难帮助有限，还常被过量乱吃。
- 收益：澄清最常见的助眠误区，见第 13 节第 1、2 条。
- 证据等级：C
- 来源：褪黑素证据边界，见第 13 节
- 备注：把"药"留到第 13 节系统讲。

12. 记睡眠日记，给诊断和治疗打底

- 成本：每天几分钟记录。
- 说人话：记下上床、入睡、起夜、起床、自评质量，连续 1–2 周。它既是医生评估的硬数据，也是你发现自己规律（如"周末必崩"）的工具。
- 收益：诊断和自我管理的基础，比手环更真实，见第 14 节。
- 证据等级：C
- 来源：睡眠日记是失眠评估标准工具，见第 3 节第 12 条、第 14 节
- 备注：和电子手环配合使用更全。

13. 失眠常和抑郁、焦虑、呼吸暂停共病，要一起查

- 成本：零。
- 说人话：很多"治不好的失眠"其实是别的病的一部分——抑郁焦虑（早醒型）、睡眠呼吸暂停（打鼾憋气）、甲状腺问题等。只盯着"助眠"治标，根没动就好不了。
- 收益：一条避免漏诊的关键原则。
- 证据等级：A
- 来源：失眠共病研究；AASM 失眠评估强调排查共病
- 备注：早醒+情绪低落见第 11 节第 13 条；打鼾憋气见第 16 节。

13. 助眠补剂与药物：什么真有用，什么只是昏你

这一节讲"实在想用药/补剂"时的边界。核心一句：先改生活方式，再谈药；药是桥不是家。口径：补剂与用药。

1. 褪黑素适合时差、轮班、晚睡综合征，不是普通安眠药

- 成本：一瓶几十到一百多元，能用很久。
- 说人话：褪黑素是"报时激素"，它帮你把生物钟拨到"该困"的相位，不负责"让你秒睡"。所以对倒时差、轮班、青少年晚睡综合征（入睡相位推迟）证据明确；对普通的"躺下睡不着"帮助有限。
- 收益：澄清最大误区——别拿它当安眠药吃，它用错场景基本无效。
- 证据等级：A
- 来源：AASM 褪黑素临床实践指南（Auger RR 等 2017. J Clin Sleep Med. https://doi.org/10.5664/jcsm.7022）；时差/轮班相关指南
- 备注：用法见第 2 条；孕妇儿童见第 11 条、第 16 节。

2. 褪黑素用法：低剂量、提前吃、短期

- 成本：零额外。
- 说人话：很多产品一给就 5–10 mg，但研究里有效的常常更低（约 0.5–3 mg）；而且要提前 1–2 小时吃，让血浓度在就寝时升上来。长期大剂量安全性未知，别天天当糖吃。
- 收益：把"怎么吃"也讲清，避免无效或过量。
- 证据等级：B
- 来源：褪黑素剂量与时相偏移的研究
- 备注：和"别乱当安眠药"（第 1 条、第 12 节第 11 条）配套。

3. 镁：对缺镁或腿抽筋者可能有点用，普通人证据弱

- 成本：一瓶几十元。
- 说人话：镁参与神经肌肉放松，但"吃镁助眠"的大规模硬证据不强。如果你是缺镁（如抽筋、饮食差）或吃利尿剂，补一点可能改善；正常人当神药就过头了。
- 收益：给"网红镁"一个客观的份量。
- 证据等级：C
- 来源：镁与睡眠的有限研究
- 备注：别和高剂量长期补，肾不好者先问医生。

4. 缬草、洋甘菊、薰衣草等草本：证据弱、品质参差

- 成本：几十元。
- 说人话：这些草本助眠在个别小试验里有一点正面信号，但总体样本小、质量不齐，剂量也没标准。可以当温和尝试，别指望它治失眠。
- 收益：把"草本=天然安全有效"的滤镜摘掉一点。
- 证据等级：C
- 来源：草本助眠剂的有限/矛盾证据综述
- 备注：草本也可能和药相互作用，长期吃前问医生。

5. 抗组胺药（苯海拉明等）能"昏"，但次日昏沉、易耐受

- 成本：很便宜。
- 说人话：很多非处方"助眠药"其实是抗过敏药，靠"嗜睡"这个副作用让你睡。问题是第二天残留昏沉、连续吃几天就耐受（越吃越没用），不算好的助眠选择。
- 收益：拆穿"药房随便买的药安全"的错觉。
- 证据等级：B
- 来源：第一代抗组胺药的镇静副作用与耐受研究
- 备注：偶尔救急可以，长期不推荐。

6. 处方安眠药（右佐匹克隆、唑吡坦等）：短期有效，遵医嘱

- 成本：挂号 + 处方费。
- 说人话："Z 药"这类非苯二氮䓬类，短期（通常数周）在医生指导下能显著缩短入睡、减少夜醒，相对安全。关键是"短期、低剂量、不自行加量"。
- 收益：客观定位处方安眠药——有效但要有边界。
- 证据等级：A
- 来源：AASM 失眠药物指南（短期使用推荐）
- 备注：长期用会依赖/反弹，见第 9 条；和 CBT-I 并行更稳。

7. 苯二氮䓬类（安定、氯硝西泮等）：易依赖，不推荐长期

- 成本：处方费。
- 说人话：这类老牌镇静药助眠也有效，但依赖、耐受、次日残留、跌倒风险（老人尤甚）都更高。指南已不推荐作为慢性失眠的常规长期用药。
- 收益：给"吃安定助眠多年"的人一个风险提醒。
- 证据等级：A
- 来源：失眠药物指南（偏好非苯二氮䓬类）
- 备注：老人跌倒风险高，见第 16 节。

8. 抗抑郁药小剂量助眠（曲唑酮、米氮平）：针对共病

- 成本：处方费。
- 说人话：有些抗抑郁药有镇静作用，医生会在"失眠合并抑郁/焦虑"时用小剂量兼顾客两种问题——这是对症用药，不是单纯当安眠药开。
- 收益：解释"为什么我开的是抗抑郁药"，避免误解。
- 证据等级：B
- 来源：镇静类抗抑郁药在失眠共病中的使用
- 备注：必须医生评估后开，别自行服用。

9. 褪黑素受体激动剂（如雷美替胺）：处方药，调节律

- 成本：处方费。
- 说人话：雷美替胺（ramelteon）专门作用于褪黑素受体、调睡眠相位，不易依赖，适合"入睡困难 + 节律问题"的人，由医生处方。
- 收益：给"怕依赖"的人一个处方备选。
- 证据等级：A
- 来源：ramelteon 的临床试验与指南
- 备注：国内可及性不如褪黑素，以医生能开到的为准。

10. 别把酒和安眠药/补剂混着用

- 成本：零。
- 说人话：酒精 + 镇静药/抗组胺会双重抑制中枢神经，呼吸被压、意外风险飙升，是真实的危险组合，绝不是"酒送药助眠"。
- 收益：一条和安全直接相关的硬警告。
- 证据等级：A
- 来源：酒精与镇静药相互作用的安全警示
- 备注：和第 7 节第 5 条（别用酒当安眠药）同源。

11. 儿童、孕妇别随意用助眠补剂或药

- 成本：零。
- 说人话：孕妇、婴幼儿用药/补剂风险不同，很多都没在儿童身上验证过。这类人群睡不好，先找原因（作息、环境、疾病），别直接上补剂。
- 收益：保护最不该乱用药的群体，见第 16 节。
- 证据等级：C
- 来源：特殊人群用药安全原则，见第 16 节
- 备注：婴儿安全睡眠见第 6 节第 10 条、第 16 节第 5 条。

12. 补剂监管松，选有第三方认证的品牌

- 成本：略贵一点。
- 说人话：补剂行业纯度、实际剂量水分大，同一成分不同牌子差很多。选有 USP、NSF、ConsumerLab 等第三方认证的，至少"瓶上写的就是瓶里有的"更可靠。
- 收益：减少"买了个寂寞甚至有害"的坑。
- 证据等级：C
- 来源：补剂监管与第三方验证的常识
- 备注：再认证也改变不了"证据弱"的事实，见第 3、4 条。

13. 先改睡眠卫生，再考虑药——顺序别反

- 成本：零。
- 说人话：药解决不了"下午咖啡 + 睡前刷手机 + 卧室像蒸笼"。那些不改，停药就反弹。正确顺序是：先把本书前十几节做了，再谈药/补剂当辅助。
- 收益：给"想直接吃药"的人指回正路，也呼应第 12 节。
- 证据等级：C
- 来源：失眠治疗顺序（行为先于药物）的指南共识
- 备注：和第 12 节第 2、5 条同源。

14. 睡眠监测与数据：别被手表带焦虑

这一节讲手环、App 和多导睡眠图。数据有用，但别让它反过来控制你。口径：数据与工具。

1. 消费级手环的"睡眠分期"不准，别当真

- 成本：一只手环几百到几千元。
- 说人话：手环靠手腕动作 + 心率来"猜"你睡了没、深睡多少，对浅睡/深睡/REM 的判定误差很大，常常把"躺着不动"算成"睡了"。当个大致趋势看可以，当诊断绝对不行。
- 收益：一条能让人少焦虑的关键事实——你的"深睡 20 分钟"可能只是手环猜的。
- 证据等级：B
- 来源：消费级设备睡眠分期准确性的验证研究（普遍低估/高估并存）
- 备注：和第 3 条配套，别被单晚数值吓到。

2. 多导睡眠图（PSG）才是金标准，但要去医院

- 成本：医院检查几百到上千元，睡一晚。
- 说人话：PSG 在身上贴十几个传感器，逐秒判读脑电、眼动、呼吸、血氧，是诊断睡眠呼吸暂停、发作性睡病等的金标准。它不是日常工具，是"有病要查"时才做。
- 收益：讲清"什么情况才值得去医院做睡眠监测"。
- 证据等级：A
- 来源：AASM 睡眠监测临床指征
- 备注：怀疑呼吸暂停/白天极度嗜睡才做，见第 16 节。

3. 别被数据焦虑：看趋势，别看单晚

- 成本：零。
- 说人话：单晚分数低，可能只是手环误差 + 你当晚状态波动。盯着每天的"深睡分钟数"反而更焦虑、更睡不着——这叫"正交焦虑"。
- 收益：把"看数据"的姿势摆正，避免工具反噬。
- 证据等级：C
- 来源：睡眠追踪焦虑（orthosomnia）的相关讨论
- 备注：和第 4 条"白天状态更准"配套。

4. 用"白天状态"比用手环分数更准

- 成本：零。
- 说人话：你白天精不精神、情绪稳不稳、专注力行不行，比手环的深睡曲线更说明"你睡够了没"。数据只是参考，身体感受才是最终裁判。
- 收益：给"唯分数论"一个纠偏。
- 证据等级：C
- 来源：主观恢复感与客观睡眠的相关研究
- 备注：和第 2 节"自由日实测"（第 5 条）同源。

5. 睡眠日记比手环更"真"（主观但诚实）

- 成本：每天几分钟。
- 说人话：你对自己"几点睡、几点醒、质量如何"的主观记录，常常比手环的算法更贴近真实体验，而且是医生最认的输入之一。
- 收益：一个零成本、被医疗系统使用的工具，见第 12 节第 12 条。
- 证据等级：C
- 来源：睡眠日记是失眠评估标准工具
- 备注：手环 + 日记组合最实用。

6. 手环适合看"总量和规律"，不适合看"质量细节"

- 成本：已买的话零额外。
- 说人话：手环在"你睡了多久、几点睡几点起、作息规不规律"上还算可用；在"深睡/REM 多少"上别较真。按它的强项用，弱项忽略。
- 收益：给出一个务实的使用边界。
- 证据等级：C
- 来源：基于设备误差特征的常识整合
- 备注：和第 1 条配套。

7. 异常数据（血氧掉、记录到呼吸暂停）值得拿去查

- 成本：零（用已有的手环）。
- 说人话：如果手环反复显示夜间血氧明显掉、或记录到成串呼吸暂停，这可能是真问题的线索（睡眠呼吸暂停）。拿给医生看，别自己吓自己也别无视。
- 收益：把"数据"变成"早筛工具"的正确用法。
- 证据等级：B
- 来源：消费设备对 OSA 的筛查价值研究（灵敏度尚可，需医院确诊）
- 备注：确诊要 PSG，见第 2 条、第 16 节。

8. 别为"达标"而焦虑，睡眠不是打卡

- 成本：零。
- 说人话：把"今晚深睡要满 1 小时、分数要过 90"当 KPI，只会让你越睡越紧。睡眠是生理，不是业绩。
- 收益：和第 3 条同源，进一步卸下数据包袱。
- 证据等级：C
- 来源：追踪焦虑（orthosomnia）讨论
- 备注：把"睡得着"放回第一位。

9. 不同 App 的"睡眠评分"口径不一，别跨 App 比

- 成本：零。
- 说人话：A 家说你深睡 1 小时、B 家说 40 分钟，因为它们算法和口径不同。换 App 就重算基线，同一晚分数没可比性。
- 收益：避免"换个 App 发现自己更差了"的无谓恐慌。
- 证据等级：C
- 来源：设备/算法间一致性差的研究
- 备注：固定用一个看趋势即可。

10. 给医生看，带"睡眠日记 + 手环总趋势"，而非单晚截图

- 成本：整理几分钟。
- 说人话：就医时，医生要的是"持续几周的规律"（几点睡起、质量如何、是否打鼾），不是某天凌晨 3 点的一张截图。带上日记和手环 2 周趋势最有效。
- 收益：让就诊更高效，见第 12 节第 12 条、第 10 条。
- 证据等级：C
- 来源：睡眠门诊采集信息的标准做法
- 备注：和第 5、12 条配套。

11. 儿童用手环更要谨慎解读

- 成本：已买的话零额外。
- 说人话：儿童睡眠本就和大人不同，手环对小孩的算法更没校准，数值偏差更大。别拿它给孩子贴"睡不好"的标签。
- 收益：避免把焦虑转移到孩子身上，见第 16 节。
- 证据等级：C
- 来源：儿科睡眠监测的适用性原则
- 备注：孩子睡眠问题看行为+作息，见第 16 节。

12. 放下"量化睡眠"的执念，睡得着比测得准重要

- 成本：零。
- 说人话：这一节的核心一句：工具是为你服务的，不是反过来。把注意力放回"规律作息、舒服环境、白天状态好"，比研究曲线更能改善睡眠。
- 收益：把整节收口到"人比数字重要"。
- 证据等级：C
- 来源：基于追踪焦虑文献的常识性结论
- 备注：和第 3、4、8 条同源。

15. 常见误区与谣言：流传最广的睡眠说法，哪些错了

这一节把最常听到的"睡眠常识"一条条过一遍，标出真假。口径：误区辨析。

1. "必须睡满 8 小时"——错，正确是 7–9 区间

- 成本：零。
- 说人话：8 小时是个被神化的整数。成年人推荐 7–9 小时，很多人 7 小时就够，硬凑 8 反而焦虑。看区间，不看单点。
- 收益：破除最常见的数字执念，见第 2 节第 1 条。
- 证据等级：A
- 来源：Hirshkowitz 2015 / Watson 2015 睡眠时长共识，见第 2 节
- 备注：长期低于 7 才是风险线。

2. "周末补觉能还清睡眠债"——错

- 成本：零。
- 说人话：平时天天欠觉，周末睡 12 小时还不上。睡眠债是慢损伤累积，且周末赖床制造社交时差，见第 1 节第 7 条、第 3 节第 2 条。
- 收益：劝退"平时熬、周末补"，见相关条。
- 证据等级：B
- 来源：社交时差与补觉研究，见第 1 节第 7 条
- 备注：偶尔补 1 小时比不补好，但别指望清零。

3. "睡前喝酒助眠"——错，反而把睡眠切碎

- 成本：零。
- 说人话：酒精让你快点昏，但下半夜反复醒、REM 砍掉、打鼾加重，醒来更累。这是全书被误解最深的一条，见第 7 节第 4、5 条。
- 收益：破除"酒=安眠"的错觉，证据很硬。
- 证据等级：A
- 来源：Roehrs & Roth 等酒精与睡眠研究，见第 7 节
- 备注：别用酒当安眠药，见第 13 节第 10 条。

4. "打鼾是睡得香"——错，可能是呼吸暂停

- 成本：零。
- 说人话：响亮不规律打鼾 + 憋气，是阻塞性睡眠呼吸暂停的信号，伤心血管，见第 1 节第 8 条、第 16 节第 3 条。
- 收益：一条能救命的识别纠正。
- 证据等级：A
- 来源：OSA 与打鼾的关联研究，见第 1 节
- 备注：尤其伴侣被目击"憋气"时更要查。

5. "数羊能催眠"——效果差，换"想象放松"更好

- 成本：零。
- 说人话：研究直接测过：数羊的人并不比什么都不做更快入睡，反而可能因"在数"而更清醒。换成想象放松场景更有效。
- 收益：一条被实验打脸的民间偏方。
- 证据等级：C
- 来源：Harvey AG 等数羊 vs 想象的分组小研究
- 备注：真正有用的是放松/呼吸，见第 11 节。

6. "失眠就吃安眠药/褪黑素"——顺序错了

- 成本：零。
- 说人话：失眠第一选择是 CBT-I 和行为改善，药/补剂是辅助。而且褪黑素根本不是普通安眠药，见第 12 节、第 13 节。
- 收益：纠正"直接吃药"的路径依赖。
- 证据等级：C
- 来源：失眠治疗顺序共识，见第 12、13 节
- 备注：短期用药可以，但别当唯一解。

7. "年纪大了觉少是正常的"——部分错

- 成本：零。
- 说人话：老年人深睡减少、易醒是事实，但"总时长该缩"不对——仍建议 7–8 小时。把"睡 5 小时"当正常，会掩盖呼吸暂停、抑郁等真问题，见第 2 节第 2 条、第 16 节第 7 条。
- 收益：纠正对老年睡眠的误解。
- 证据等级：A
- 来源：老年睡眠时长建议，见第 2 节
- 备注：白天嗜睡要查因，见第 10 节第 11 条。

8. "躺够时间就等于睡够"——错，质量也重要

- 成本：零。
- 说人话：躺在床 8 小时但全是浅睡、反复醒，不等于睡够。这也是睡眠效率（实际睡着/卧床）的概念，见第 12 节第 4 条。
- 收益：解释"为什么我躺很久还是累"。
- 证据等级：C
- 来源：睡眠效率概念
- 备注：睡眠限制疗法正是针对这点。

9. "中午不能睡，睡了晚上不困"——错，短睡不影响

- 成本：零。
- 说人话：20–30 分钟短午睡提神又不抢夜间睡眠；只有睡太久/太晚才影响晚上，见第 10 节第 1、4 条。
- 收益：给"不敢午睡"的人松绑。
- 证据等级：B
- 来源：午睡时长研究，见第 10 节
- 备注：失眠者除外，见第 10 节第 5 条。

10. "运动后马上能睡更好"——错，剧烈反而兴奋

- 成本：零。
- 说人话：运动后体温和肾上腺素要几小时才退，睡前剧烈运动反而难睡；高强度放白天，睡前只做温和拉伸，见第 8 节第 2 条。
- 收益：纠正"练完倒头就睡"的想象。
- 证据等级：B
- 来源：运动时机与睡眠研究，见第 8 节
- 备注：温和瑜伽睡前可以，见第 8 节第 4 条。

11. "安眠药一吃就依赖，绝对不能碰"——也错

- 成本：零。
- 说人话：短期（数周）、遵医嘱、低剂量使用处方安眠药是安全且有效的，指南明确推荐。妖魔化和滥用都错，见第 13 节第 6、9 条。
- 收益：给"谈药色变"的人客观定位。
- 证据等级：A
- 来源：AASM 失眠药物指南，见第 13 节
- 备注：长期自行加量才危险。

12. "做梦 = 没睡好"——错，做梦是正常 REM

- 成本：零。
- 说人话：做梦多发生在 REM 期，是健康睡眠的必要部分（整理记忆、调节情绪）。记得梦只说明你从 REM 期醒来，不代表睡差，见第 1 节第 5 条。
- 收益：纠正"做梦=没休息"。
- 证据等级：A
- 来源：REM 与做梦的睡眠生理，见第 1 节
- 备注：噩梦频繁才要关注。

13. "屏幕开了夜间模式就无害"——错，减不净

- 成本：零。
- 说人话：夜间模式能减一点蓝光，但内容刺激还在、蓝光也没清零。最稳还是"睡前一小时不碰亮屏"，见第 4 节第 3 条、第 9 节第 1、2 条。
- 收益：给"开了护眼模式就放心刷"的人降温。
- 证据等级：B
- 来源：滤蓝光对褪黑素抑制的部分缓解研究，见第 9 节
- 备注：和第 9 节第 2 条同源。

16. 特殊人群与场景：轮班、时差、打鼾、孕老幼怎么办

这一节把前面分散在各节的"特殊情形"收拢：不同人群的真实做法。口径：特殊人群。

1. 轮班工作：固定"假起床时间"，下班挡光、白天暗房睡

- 成本：墨镜 + 遮光帘几十元。
- 说人话：轮班最伤的是生物钟被反复拉扯。尽量固定一个"起床/就寝"锚点；下班路上戴墨镜挡晨光，回家把卧室弄到伸手不见五指再睡；必要时白天短 nap 补点料。
- 收益：给轮班族一套可操作的光-遮光-小睡组合，比"硬睡"有效得多。
- 证据等级：B
- 来源：AASM 轮班工作睡眠障碍指南；光/遮光干预研究（见第 4 节第 9、13 条、第 10 节第 12 条）
- 备注：频繁倒班者优先申请固定班次或顺时针调班。

2. 倒时差：按目的地钟调，晨光 + 短程褪黑素

- 成本：几十元（褪黑素）。
- 说人话：落地后一切按当地时间：白天（尤其上午）多晒、晚上避光，起床时间钉死。向东飞（时间提前）最难，可短期用低剂量褪黑素帮相位前移，见第 4、13 节。
- 收益：把"倒时差"从硬扛变成有步骤的调整。
- 证据等级：B
- 来源：时差调整指南；褪黑素对时差的证据（见第 4 节第 7 条、第 13 节）
- 备注：每跨 1 个时区约需 1 天适应。

3. 阻塞性睡眠呼吸暂停（OSA）：减重 + 侧睡 + CPAP

- 成本：CPAP 呼吸机几千元（多数医保可报），长期。
- 说人话：打鼾 + 憋气 + 白天极度嗜睡，先去确诊。中重度用 CPAP（持续正压通气）能把塌陷的气道撑开，显著降心血管风险、改善白天状态；减重、侧睡、戒酒也能减轻。
- 收益：一条能显著改善预后、甚至救急的建议，优先级最高。
- 证据等级：A
- 来源：PAP 治疗 OSA 的临床指南；Peppard 2013 等患病率/风险研究（见第 1 节第 8 条）
- 备注：和第 1 节第 8 条、第 6 节第 4 条配套；别只靠"止鼾枕"。

4. 孕妇：左侧卧、控咖啡因、严重打鼾要查

- 成本：孕妇枕几十到几百元。
- 说人话：孕中晚期仰卧会压血管、加重不适，左侧卧（或左右交替）更轻松，用孕妇枕托住；咖啡因要控（下午 cutoff 更严）；若孕期打鼾加重甚至憋气，要排查，见第 6 节第 5 条、第 7 节、第 2 节第 11 条。
- 收益：给准妈妈一份贴合孕期的睡眠清单。
- 证据等级：B
- 来源：ACOG 孕期建议；孕期睡眠与 OSA 研究
- 备注：安眠补剂/药别随意用，见第 13 节第 11 条。

5. 婴幼儿：仰睡、硬床垫、无软物（防 SIDS）

- 成本：换硬一点的婴儿床垫几十元。
- 说人话：1 岁内婴儿猝死综合征的可控因素：让婴儿仰睡、用硬床垫、床上不堆软枕/厚被/毛绒玩具。同床喂养后要把婴儿放回自己的床。
- 收益：一条优先级远高于"舒服"的安全准则。
- 证据等级：A
- 来源：美国儿科学会（AAP）婴儿安全睡眠指南，见第 6 节第 10 条
- 备注：和"儿童睡具"配套，见第 6 节。

6. 青少年：推迟上学钟点、严格限睡前屏

- 成本：零，需要学校+家长配合。
- 说人话：青春期生物钟天然推迟（晚睡晚起），叠加学业和手机，睡眠被严重挤压。证据表明推迟上学钟点能改善睡眠和情绪；睡前限屏、设备离卧室也明确有效，见第 2 节第 3 条、第 9 节第 13 条。
- 收益：保护最需要睡眠、又最易被手机绑架的群体。
- 证据等级：A
- 来源：青少年睡眠与推迟上学钟点的研究，见第 2、9 节
- 备注：家长以身作则比说教有用。

7. 老年人：排查嗜睡原因、防起夜跌倒

- 成本：零。
- 说人话：老人睡得碎、易醒是结构变化，但"白天老睡不醒"要查病因（呼吸暂停、抑郁、药物、起夜）。同时夜里起身慢一点、床边留灯，防跌倒，见第 2 节第 2 条、第 10 节第 11 条。
- 收益：把"老年睡眠"从"认命"变成"会查会防"。
- 证据等级：C
- 来源：老年睡眠评估与跌倒预防建议
- 备注：安眠药在老人身上跌倒风险更高，见第 13 节第 7 条。

8. 伴抑郁/焦虑者：先治情绪，睡眠才稳

- 成本：挂号 + 治疗。
- 说人话：失眠常是抑郁/焦虑的一部分（尤其早醒型）。只治"睡不着"治不好，情绪稳了睡眠才回得来；必要时用小剂量镇静抗抑郁药，见第 11 节第 13 条、第 13 节第 8 条。
- 收益：避免"失眠治半年没用"的漏诊。
- 证据等级：A
- 来源：失眠-情绪共病研究，见第 11、12 节
- 备注：有自伤念头立即就医，不拖延。

9. 慢性疼痛者：先控疼痛，再调睡姿与放松

- 成本：治疗疼痛的花费。
- 说人话：疼痛是睡眠的硬干扰，先和医生把疼痛控住；再用合适睡姿（如膝下垫枕）、温和放松训练、睡前热敷等减轻夜间不适。
- 收益：给"疼得睡不着"的人一个分层思路。
- 证据等级：C
- 来源：疼痛与睡眠互作的临床建议
- 备注：放松技术见第 11 节。

10. ADHD / 神经多样性人群：作息更需结构化

- 成本：零。
- 说人话：ADHD 等群体常伴延迟睡眠相位、更难启动睡前流程。用强结构（固定闹钟、视觉提醒、缓冲带）和"先睡后玩"的规则，比靠意志更稳。
- 收益：给神经多样性人群一个友好、可执行的做法。
- 证据等级：C
- 来源：ADHD 与睡眠节律的相关研究
- 备注：和第 3 节（固定作息）、第 9 节（睡前仪式）配套。

11. 夜醒频繁/起夜多：傍晚限水 + 查前列腺/膀胱

- 成本：零，必要时就医。
- 说人话：睡前 2 小时少喝水能减少夜尿；若仍每夜起夜 2–3 次，男性查前列腺、所有人排查膀胱/糖尿病等因素，而不是只怪"失眠"，见第 7 节第 8 条。
- 收益：把"夜醒"从失眠框架里拆出"泌尿"病因。
- 证据等级：C
- 来源：夜尿（nocturia）临床评估建议
- 备注：男性中老年起夜多优先泌尿科。

12. 倒班哺乳妈妈：和家人轮班、把补觉排第一

- 成本：零。
- 说人话：新生儿期睡眠必然碎，关键是别硬撑——和家人排好喂奶轮班，趁宝宝睡时自己也睡，把"补觉"当正事。短 nap（第 10 节）和遮光环境都用上。
- 收益：减轻产后睡眠剥夺，对新手妈妈情绪也重要。
- 证据等级：C
- 来源：产后睡眠与情绪的临床建议
- 备注：持续情绪低落排查产后抑郁，见第 8 条。

13. 某些常用药会干扰睡眠，留意并和医生调

- 成本：零。
- 说人话：一些常见药会影响睡眠：平喘药（平喘药中的茶碱/β激动剂）、部分抗抑郁药、β受体阻滞剂、糖皮质激素、某些减肥药等。若用药后明显失眠，和医生商量调时间或换药，别硬扛。
- 收益：指出一类常被忽略的药物性失眠。
- 证据等级：C
- 来源：药物不良反应与睡眠的文献
- 备注：勿自行停药，先咨询医生。

14. 旅行/酒店睡眠：眼罩耳塞 + 固定作息 + 白噪音

- 成本：眼罩耳塞几十元。
- 说人话：陌生床、光、噪音和时差都干扰酒店睡眠。带上遮光眼罩和耳塞、尽量保持原有作息、用白噪音盖背景声，能把"在外睡不好"的损失降到最低。
- 收益：给频繁出差/旅行的人一套便携方案。
- 证据等级：C
- 来源：旅行睡眠与睡眠卫生习惯的整合（见第 5 节第 2 条、第 4、10 节）
- 备注：跨时区叠加第 2 条的倒时差做法。